

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

EAP DE ODONTOLOGÍA



PROYECTO DE TESIS

Nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

AUTOR:

Annie Lizet Caruajulca Cieza

ASESOR:

Mg. Livia Sonia Zambrano de la Peña

Lima, Perú

2025

INDICE DE CONTENIDO

1. TÍTULO.....	4
2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN.....	4
2.1. ÁREA DEL PROBLEMA.....	4
2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA	6
2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	6
2.4. OBJETIVOS.....	7
2.4.1. OBJETIVO GENERAL.....	7
2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
2.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	8
2.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN	9
3. MARCO TEÓRICO.....	9
3.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA	9
3.2. BASES TEÓRICAS.....	16
3.2.1. Conocimientos, actitudes y prácticas.....	16
3.2.1.1. Conocimiento	16
3.2.1.2. Actitudes.....	17
3.2.1.3. Prácticas	19
3.2.2. Bioseguridad.....	19
3.2.2.1. Principios de bioseguridad	20
3.2.2.1.1. Universalidad	20
3.2.2.1.2. Uso de barreras	20
3.2.2.1.3. Medidas de eliminación de materiales contaminados.....	20
3.2.2.2. Protocolo de bioseguridad surgido en contexto de la COVID-19.....	21
3.2.2.2.1. Recomendaciones previas a la recepción de pacientes	21
3.2.2.2.1.1. Establecimiento de las citas	21
3.2.2.2.1.2. Disposiciones en la sala de Espera.....	21
3.2.2.2.1.3. Disposiciones en los Servicios Higiénicos	22
3.2.2.2.2. Recomendaciones durante la recepción de pacientes.....	22
3.2.2.2.3. Recomendaciones previas a la atención de pacientes.....	23
Indicaciones antes del uso de EPP.....	24
3.2.2.2.4. Recomendaciones durante la atención estomatológica	25
3.2.2.2.4.1. Examen Estomatológico	26
3.2.2.2.4.2. Procedimientos Estomatológicos.....	26
3.2.2.2.5. Recomendaciones posteriores a la atención estomatológica.....	27
3.2.2.2.5.1. Manejo y eliminación de residuos	32

3.2.2.3.	Medidas de bioseguridad frente a accidentes de exposición a sangre o fluidos corporales (AES).....	33
3.2.2.3.1.	Riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas por AES	34
3.2.2.3.2.	Conductas por seguir ante un AES.	35
3.2.2.3.3.	Profilaxis Post Exposición (PPE)	37
3.2.2.3.3.1.	Procedimiento de actuación ante casos de VIH.....	37
3.2.2.3.3.3.	Procedimiento de actuación en casos de Hepatitis C	38
3.3.	DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.....	38
3.3.1.	Conocimiento	38
3.3.2.	Actitudes	39
3.3.3.	Práctica	39
3.3.4.	Bioseguridad:.....	39
3.3.5.	Fuente:	39
3.4.	HIPÓTESIS.....	40
3.5.	OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.....	41
4.	METODOLOGÍA.....	43
4.1.	TIPO DE INVESTIGACIÓN	43
4.2.	POBLACIÓN Y MUESTRA.....	43
4.2.1.	POBLACIÓN.....	43
4.2.2.	MUESTRA.....	43
4.2.2.1.	CRITERIOS DE INCLUSIÓN	44
4.2.2.2.	CRITERIOS DE EXCLUSIÓN	44
4.2.2.3.	UNIDAD DE ANÁLISIS.....	44
4.3.	TÉCNICA, PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	44
4.4.	PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS	46
4.5.	ASPECTOS ÉTICOS.....	47
5.	ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	47
5.1.	RECURSOS	47
5.2.	PRESUPUESTO	47
5.3.	FINANCIAMIENTO.....	48
5.4.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	49
6.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	50
7.	ANEXOS	55

1. TÍTULO

Nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. ÁREA DEL PROBLEMA

La bioseguridad representa a un conjunto de medidas preventivas que tienen por finalidad controlar factores de riesgos provenientes de agentes biológicos, físicos y/o químicos, evitando así la infección cruzada y la propagación de enfermedades entre el profesional, personal de salud y los pacientes.(1)

Con la aparición del SARS COV-2 en el año 2019, la bioseguridad en la odontología alcanzó su máximo nivel, ya que la profesión fue considerada por la Agencia Americana de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSa) como una de las profesiones de mayor riesgo de exposición del virus (2)(3) debido al contacto directo con los pacientes, fluidos (saliva, sangre) y sobre todo a la presencia de aerosoles emitidos durante los procedimientos dentales (4)(5) razón por la cual la práctica odontológica requirió de protocolos de bioseguridad mucho más rigurosos, con aplicación de forma obligatoria por todos los profesionales durante la atención de los pacientes.

A pesar que las instituciones internacionales (OMS, ADA, CDC, etc) y nacionales como el MINSA, brindaron una serie de directrices y disposiciones específicas sobre protocolos de bioseguridad en atención estomatológica aplicables para el contexto de pandemia y post pandemia, se ha observado algunas deficiencias con respecto al nivel de conocimientos y actitudes sobre protocolos de bioseguridad por parte de odontólogos peruanos, en cuyos resultados indicaron niveles de conocimientos regulares en la mayoría de los casos(6)(7)(8). De forma similar, diversos estudios desarrollados en distintos países del mundo corroboran los resultados encontrados en el Perú, indicando conocimientos de regulares a buenos.(9)(10)

Por ende, se puede extrapolar a que muchos odontólogos podrían presentar deficiencias al seguir protocolos de bioseguridad durante la atención clínica, y más aún, en un contexto posterior a la crisis pandémica, donde la mortalidad y la morbilidad generadas por el virus de Covid-19 ha disminuido. Además, de informarse que el uso del EPP obligatorio en la pandemia se asoció con menor eficiencia laboral y visibilidad reducida del campo operatorio, lo que podría conllevar a la pérdida paulatina de rigurosidad sobre las medidas de bioseguridad por parte de los profesionales de Odontología en la postpandemia(11). Por ello, se debe continuar con investigaciones en más poblaciones de odontólogos para lograr profundizar el tema y así brindar una atención de calidad y segura a los pacientes.

En la Odontología además, el control de infecciones representa un gran reto debido al alto riesgo de transmisión de enfermedades en el consultorio ya que, la contaminación cruzada se puede dar por distintas rutas de transmisión como: contacto directo con sangre u otros fluidos corporales, contacto indirecto por medio de objetos contaminados (instrumentos, superficies, equipos), contacto con mucosa conjuntival, nasal u oral e inhalación de microorganismos que quedan suspendidos en el aire por periodos prolongados. (12) Además, la transmisión de infecciones graves se puede producir por accidentes laborales con objetos punzocortantes como jeringas del anestésico local, retapado de agujas dentales, limpieza de instrumentos, cambios de cárpule, etc. Dejando al odontólogo altamente vulnerable a la exposición.(13) Por lo cual el profesional debe estar adecuadamente capacitado sobre protocolos de bioseguridad.

2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

En el Perú contamos con el aporte de las instituciones nacionales como: COP, COL, el MINSA que han ido incorporando y modificando algunas medidas de bioseguridad plasmándolas en la Directiva Sanitaria N°100- Manejo de la atención estomatológica, en el contexto de pandemia por Covid-19. Estos mismos protocolos serán adaptados para un escenario posterior a la pandemia y deberán ser cumplidos de forma obligatoria y estricta por todos los profesionales de odontología, para evitar infecciones cruzadas y poder brindar una atención de calidad a los pacientes(14)(15) .

En las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) del sector público, sobre todo del nivel primario de atención como son los centros de salud, se brinda atención generalmente a poblaciones vulnerables y de bajos recursos económicos. Por lo tanto, es importante investigar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre las medidas de bioseguridad en los odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro durante el año 2025.

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, en el año 2025?

2.4. OBJETIVOS

2.4.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, en el año 2025.

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar el nivel de conocimientos sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, según distrito en el que labora, años de experiencia, edad y sexo.
- Evaluar las actitudes sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, según distrito en el que labora, años de experiencia, edad y sexo.
- Identificar las prácticas en cuanto a medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, según distrito en el que labora, años de experiencia, edad y sexo.
- Establecer la relación entre el nivel de conocimientos, las actitudes y las prácticas sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

2.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

APORTE TEÓRICO: La presente investigación busca brindar en una visión real el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas que presentan los odontólogos sobre las medidas de bioseguridad, que por medio de la aplicación de conceptos básicos sobre medidas de bioseguridad se logre reforzar ciertas funciones que el odontólogo debe aplicar para mantener su integridad y la de sus pacientes. De modo así que las diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la DIRIS Lima Centro puedan complementar y/o mejorar sus protocolos de bioseguridad según sus necesidades. Además, los resultados pueden ser analizados y servir de referencia para que el sector estudiado e incluso otras DIRIS de Lima y del Perú y otras instituciones, realicen seguimiento continuo sobre medidas de bioseguridad y puedan implementar programas de educación continua o estrategias que refuercen la formación y finalmente su aplicación de dichas medidas en sus odontólogos.

APORTE METODOLÓGICO: El estudio cuenta con la elaboración de un propio instrumento capaz de medir las variables estudiadas, debido a que no se encontró un instrumento idóneo que se adapte a la realidad y a los objetivos del estudio. Los cuestionarios han sido validados por medio de juicio de expertos y serán sometidos a comprobación de su confiabilidad. De esta manera se contribuye con la investigación de problemas similares y ser de referente para futuras investigaciones.

APORTE PRÁCTICO: La investigación se realiza con la finalidad de mejorar el nivel de conocimientos, actitudes y las prácticas sobre medidas de bioseguridad de los cirujanos dentistas del sector a evaluar y así, brindar tratamientos seguros.

APORTE SOCIAL: El estudio presenta relevancia social y clínica, porque será de utilidad para los pacientes que acuden en los centros públicos del nivel primario de la DIRIS Lima Centro ya que recibirán una atención de calidad enfocada a proteger su vida, salud e integridad. Así mismo, será útil para los odontólogos, puesto que diariamente en su práctica clínica están en contacto

con pacientes con distintas enfermedades orales y sistémicas, y que necesiten reforzar conocimientos para disminuir la contaminación cruzada e infecciones transmisibles en el consultorio.

2.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Dentro de las limitaciones se pueden considerar a la actitud poco colaborativa de los odontólogos durante la aplicación de los instrumentos para la recolección de datos.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Rostamzadeh M y cols (2018).(16) Con el objetivo de evaluar los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los odontólogos con respecto al control de infecciones por los virus de la hepatitis B (VHB), hepatitis C (VHC) y el VIH/SIDA en Irán. En un estudio transversal participaron 106 odontólogos, quienes respondieron a un cuestionario validado conformado en 4 partes, correspondientes con: datos demográficos, Conocimientos, actitudes y prácticas. En los resultados obtuvieron puntuaciones medias para el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de 37.30 ± 3.01 , 22.9 ± 4.80 y 24.07 ± 5.06 respectivamente. En conclusión, sostiene que los odontólogos demostraron un nivel moderado en cuanto a conocimientos y actitudes; sin embargo, hay algunas deficiencias con respecto a las prácticas.

Salazar O (2018).(17) En su estudio con la finalidad de determinar el nivel de conocimientos sobre bioseguridad en odontólogos de la región Amazonas. Mediante estudio observacional, descriptivo y transversal donde 90 odontólogos respondieron un cuestionario validado el cual incluía 3 partes: Principios de universalidad, uso de barreras y manejo de residuos. En sus resultados el nivel de conocimiento general sobre bioseguridad fue alto en el 64.4 %, medio en el

34.4% y bajo en el 1.1%. El conocimiento en cuanto a principios de bioseguridad, uso de barreras y manejo de residuos fue regular en el 69%, 57% y 77% respectivamente.

AlAhdal A y Col (2019).(18) Con el objetivo de evaluar el nivel de conocimientos, la actitud y la práctica de las medidas de control de infecciones de los profesionales de la salud dental del sector privado en Jeddah en Arabia Saudita. Aplicaron un cuestionario auto administrado en 245 dentistas, donde obtuvieron que el 7.3% de participantes no estaba vacunado contra el VHB, el 26.9% no era consciente de que el riesgo de contraer una infección por VHB es mayor que el VIH en la práctica dental. El 55.5% no eran conscientes del manejo de las lesiones por pinchazos con agujas y objetos punzocortantes. EL 33.5% asumía que el uso de guantes reemplaza al lavado de manos, el 3.3% no realizó higiene de manos luego de atender a cada paciente y el 46.5% no sabía la duración correcta para el lavado de manos. El 24.9% doblada las agujas después de usarlas, el 27.3%no usaba bata y el 5.7% no usaba mascarilla durante la atención del paciente. Sostienen, en conclusión, mejorar el nivel de conocimiento y prácticas de las medidas de control de infecciones en los participantes.

Paz M. (2019).(19) Realizó un estudio con el objetivo de describir los conocimientos, actitudes y prácticas de normas de bioseguridad y riesgo biológico en odontólogos que ejercen práctica privada en Nicaragua. Por medio de estudio descriptivo y transversal, donde participaron 86 odontólogos y respondieron a un cuestionario semiestructurado validado. Encontró como resultados que el 98.8 % de odontólogos conocen el concepto de riesgo biológico, sin embargo, el 76.7% no conocen el nombre del agente específico ni las vías de entrada al organismo, el 60.4% realizan lavado de manos antes y después de cada procedimiento, el 48.8% tienen nociones de actuación frente a los accidentes percutáneos, las actitudes son buenas en el 78% y el 68.6% con respecto a desinfección y esterilización de instrumentales y equipos respectivamente, así como, de bioseguridad personal en el 98.8%. Concluye,

que los odontólogos presentaron un conocimiento regular, la actitud positiva y buenas prácticas de bioseguridad.

Mahasneh AM y Col. (2020).(20) Desarrollaron un estudio con el objetivo de determinar el nivel de prácticas sobre el control de infecciones entre dentistas y profesionales de la salud dental en Jordania. En un estudio transversal con 190 participantes, mediante un cuestionario validado que incluía: aspectos sociodemográficos, características profesionales y recomendaciones sobre el control de infecciones. En los resultados se obtuvo que el 64.7% eran odontólogos, el 82.1% estaba vacunado contra la hepatitis B, el 66.3% y el 83.2% se lavaba las manos antes y después de cada tratamiento respectivamente, el 87.9% y el 78,9 % usa guantes y mascarilla respectivamente durante los procedimientos, el 90.5% esteriliza en autoclave y el 88.4% utiliza contenedores rígidos para punzocortantes, además, el 81% tiene protocolos de actuación ante accidentes por punzocortantes. En conclusión, sostienen que, la medida de control ante infecciones en los participantes es muy buena.

Espinoza F. (2020). (8)Desarrolló un estudio para determinar los conocimientos y actitudes de los cirujanos dentistas de Lima frente al Covid-19. Mediante un estudio transversal y descriptivo aplicó un instrumento virtual de 20 preguntas previamente validado por juicio de expertos, en una muestra de 236 odontólogos, obtuvo que el nivel de conocimientos fue bajo en el 53.3%, medio en el 62.7% y alto en el 3.8%, con respecto a las actitudes el 5.1 % tuvieron actitudes negativas, el 0.8% actitudes indiferentes y el 94.1% actitudes positivas. Concluyendo que el nivel medio de conocimientos fue predominante 62.7% y solo el 3.8% lograron niveles altos.

Sarfaraz y Col. (2020)(21). Determinaron el nivel de conocimiento y la actitud de los odontólogos en relación con la desinfección ante la Covid-19. Mediante estudio transversal utilizaron una encuesta virtual con 17 ítems, con una muestra total de 385 participantes. Los resultados indican, con respecto al nivel de conocimientos el 88.8% presentaban conocimientos inadecuados sobre desinfección contra el Covid-19. Sin embargo, el 89.9% mostró actitud positiva

hacia la desinfección contra el Covid-19. Concluyen que existe una falta de conocimiento de los odontólogos con respecto a aspectos fundamentales de protocolos de desinfección, a pesar de la disposición de pautas excepcionales que existen sobre desinfección contra Covid-19.

Nasser y cols. (2020)(22). Evaluaron el conocimiento y las prácticas de los odontólogos del Líbano frente la pandemia por Covid-19. En un estudio transversal en 358 odontólogos aplicaron un cuestionario virtual que incluía conocimiento, prácticas, miedo y percepción hacia acciones implementadas. Obtuvieron que el 91.3% presentó niveles buenos de conocimientos, sin embargo, hubo deficiencias con respecto a periodo de incubación, transmisión y modos de acción para tratar con pacientes sospechosos o confirmados con la enfermedad. En relación con las prácticas, se registraron buenas prácticas en el 58.7% y malas en el 41.3%. Además, el 80% tenían miedo de tratar pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19. Concluyeron en que el conocimiento fue bueno, sin embargo, los odontólogos presentaban comprensión limitada hacia las medidas adicionales de protección contra el Covid-19.

Srivastava y Col (2020)(9). Con la finalidad de establecer los conocimientos, actitudes y prácticas con referente a la Covid-19 en los profesionales de la salud dental de Arabia Saudita. Mediante estudio transversal aplicaron una encuesta virtual validada de 44 preguntas en 318 odontólogos. Obtuvieron un nivel de conocimiento moderado en el 51.6%, actitud positiva en el 92.1% y estándares de prácticas adecuadas en el 86.5%. Concluyeron que los profesionales presentan un nivel promedio de conocimientos y que este debería mejorarse por medio de programas de educación continua. Sin embargo, presentaron actitudes positivas y las prácticas fueron favorables debido a que seguían pautas emitidas por agencias de salud nacionales e internacionales.

Almas y Col (2020)(23). Determinaron el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas clínicas de los odontólogos con respecto a la prevención y control de la enfermedad por COVID-19 en Pakistán. En un estudio descriptivo y transversal por medio de un cuestionario virtual validado, en 343 odontólogos generales y especialistas. Obtienen una puntuación media de conocimiento de 16.78 ± 2.25 . Con respecto a la actitud solo el 15.5% se sentía cómodo tratando pacientes. En cuanto a procedimientos el 91.2% realizan únicamente procedimientos de emergencia, mientras el 6.5% refiere no realizar ningún tipo de procedimiento odontológico. Concluyen que los participantes cuentan con conocimientos adecuados, sin embargo, solo la mitad de ellos disponen de protocolos clínicos según directrices.

Borja y Col (2020)(24). La finalidad fue determinar el nivel de conocimiento sobre la enfermedad de la COVID-19 en odontólogos de Lima y Callao. En un estudio observacional, descriptivo y transversal en 1047 odontólogos colegiados; mediante una encuesta virtual validada por expertos, que incluía 5 ítems para datos generales y 15 ítems para medir la variable. En sus resultados indican que los niveles de conocimiento fueron intermedios en 84.1 % de los odontólogos, seguido del 11.3 % con un nivel alto y 4.6% un nivel bajo. Concluyendo que el nivel de conocimiento sobre medidas de control por COVID-19 fueron mayoritariamente intermedios y que los odontólogos que presentaron niveles altos se caracterizaron por ser del sexo masculino, tener más de 11 años de experiencia y ser especialistas en periodoncia/ implantología.

Pérez I y Valverde M. (2021)(7). Desarrollaron una investigación para determinar el nivel de conocimiento de los odontólogos del sector privado de Piura sobre los protocolos de bioseguridad durante el covid-19. Por medio de un estudio prospectivo, transversal, observacional y descriptivo, aplicando un instrumento de 20 preguntas en una muestra de 244 odontólogos se obtuvo un nivel de conocimientos bajo en el 35.66 %, regular en el 38.52% y alto en el 25.82%. Por ello, concluye que el nivel de conocimientos es predominantemente regular.

Turska y Col. (2021)(25). Con el objetivo de analizar el conocimiento y la actitud de los dentistas polacos sobre el SARS-COV-2 y los principales problemas de trabajo durante la fase inicial de la pandemia. En estudio transversal en 730 odontólogos, aplicaron una encuesta virtual de 57 ítems. Obtuvieron que el 95.5% tenía conocimientos sobre Covid-19, el 56% presentaba preocupación por la pandemia y el 23.6% estaba significativamente ansioso. A la vez, el 42.1% considera al lugar de trabajo como alto riesgo de infección del Covid-19. El 84% de los pacientes ingresan al consultorio pasando por triaje y usando equipos de protección individual. Concluyen que los odontólogos presentan suficiente conocimiento y están actualizados con la información acerca de protocolos ante el Covid-19. Sin embargo, existe preocupación y ansiedad ante la situación.

Koc y cols. (2021)(26). Con la finalidad de evaluar conocimientos, actitudes y prácticas en odontopediatras turcos que atendieron a pacientes durante la pandemia de Covid-19. Utilizaron una encuesta virtual en 200 odontopediatras. Obtuvieron que el 82% realizó tratamientos de emergencia, el 18% realizó tratamientos de rutina y emergencia. El 72.5% prescriben analgésicos y antibióticos a los pacientes que no cooperan al manejo de conducta no farmacológica. Concluyen que los odontopediatras presentaban buen nivel de conocimientos contra el Covid-19 y realizan adecuadas medidas de control de infecciones antes y después de sus tratamientos, sin embargo; deben continuar y seguir directrices universales y locales, además, de la implementación con programas de educación actualizadas hacia estrategias de manejo de Covid-19.

García y Col (2021)(27). Con el objetivo de determinar en nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas sobre el manejo de atención estomatológico durante el contexto de la pandemia COVID-19 en Piura. Mediante estudio cuantitativo, observacional, descriptivo y transversal y utilizando un cuestionario de 20 ítems, validado por juicios de expertos en 268 odontólogos. Los resultados indican que el 70.1 % presentaron nivel regular de conocimientos, un 14.9 % un nivel alto y de similar forma un 14.9% un nivel bajo de conocimientos. Concluyen que el nivel de conocimiento es mayoritariamente regular.

Vega K. (2022)(6). Con la finalidad de determinar el nivel de conocimientos de los cirujanos dentistas generales y especialistas de Lima Metropolitana con respecto a protocolos de bioseguridad para la atención odontológica en el contexto del Covid-19. En un estudio transversal y descriptivo en 240 odontólogos (120 generales y 120 especialistas clínicos) por medio de una encuesta virtual de 20 preguntas. Los resultados obtenidos indican que el nivel de conocimientos fue medio en el 70.8%, y no se encontró relación con los años de experiencia. Adicionalmente, obtuvo que los odontólogos especialistas obtuvieron niveles altos de conocimientos (12.5%) con mayor frecuencia que los odontólogos generales (1.7%).

Almarghlani y col. (2022)(10). Con el objetivo de evaluar el conocimiento, la actitud, la práctica y la percepción de riesgo de la exposición ocupacional a la Covid-19 sobre el control de infecciones en odontólogos de diferentes nacionalidades. Por medio de un cuestionario virtual en inglés de 33 ítems que incluía datos demográficos, conocimiento, percepción de riesgo laboral de las infecciones por Covid-19. Participaron 300 odontólogos multinacionales. Los resultados indican puntuaciones promedio de 49.38 ± 27 para el conocimiento, 41.28 ± 19.8 para la actitud, 62.76 ± 18.7 para la práctica y 39.69 ± 23.5 para la percepción de riesgo. Concluyen que los odontólogos presentaban un adecuado cumplimiento según instrucciones institucionales. Además, refieren que los participantes sienten miedo al Covid-19 y al hecho de ser potenciales transmisores, sin embargo; la mayoría presenta confianza durante la atención de pacientes positivos para covid-19.

Tamara D. (2023)(28). Con la finalidad de establecer la relación entre el nivel de conocimientos y las actitudes de los odontólogos de las IPRESS públicas nivel I de la DIRIS Lima Centro sobre el control de la infección del Covid -19. En un estudio cuantitativo, observacional, transversal y correlacional. Utilizó un instrumento que incluía 2 cuestionarios: uno de conocimientos (18 ítems) y otro para actitudes (13 ítems), validados mediante juicio de expertos, en 131

odontólogos de la DIRIS Lima Centro. En sus resultados obtuvo que el nivel de conocimientos fue malo en el 12.4%, regular en el 76.2% y bueno en el 11.4%, con respecto a las actitudes de obtuvo un nivel de malo en el 3.8%, regular en el 28.6% y bueno en el 67.6%. Concluyendo que el nivel de conocimientos fue regular en el 76.2% y las actitudes fueron buenas en el 67.6%, sin embargo, no se obtuvo una relación significativa entre ambas variables.

Rafeek y cols (2023)(29). Con el fin de evaluar el conocimiento, la actitud y las prácticas de los odontólogos de Trinidad y Tobago durante la pandemia por Covid-19. Aplicaron un cuestionario virtual en 153 odontólogos. Obtienen que con respecto a conocimiento: adecuado conocimiento sobre covid-19, uso de EPP y Mascarillas N95 en el 94.8%, 98.7% y 93.5% respectivamente, sin embargo; fue deficiente con respecto a reutilización de mascarillas N95 en el 27.5%. El 34.9% sentía comodidad durante la atención de pacientes sospechosos y confirmados por Covid-19, mientras que el 64.5% temía ser contagiado por su paciente. Además, el 97.4% y el 67.3% usaban EPP y mascarillas N95 respectivamente y que el 90.8% aceptaba la vacunación inmediata. Concluyen que los odontólogos presentan buenos niveles de conocimiento, actitud y prácticas contra la Covid-19 y alto nivel de aceptación hacia la vacuna.

3.2. BASES TEÓRICAS

3.2.1. Conocimientos, actitudes y prácticas

3.2.1.1. Conocimiento

El concepto de conocimiento según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se refiere a la acción o efecto de conocer, averiguar haciendo uso de las facultades intelectuales, la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Para el diccionario de Oxford el conocimiento representa la

comprensión alcanzada por medio de la experiencia, la observación o el estudio.(30)

En el campo de la salud el conocimiento está relacionado con medidas que prevengan y tengan la finalidad el control de factores de riesgo en el centro laboral, siendo este conocimiento adquisitivo, conservativo y elaborativo(31). Además, el conocimiento en salud tiene que ver con la investigación básica o tradicional necesaria para generar nuevos conocimientos, tecnologías y lograr mejores intervenciones para los problemas de salud(30).

3.2.1.1.1. Tipos de conocimiento. Podemos mencionar a los siguientes:(32)

- **Conocimiento Empírico.** Es aquel que surge por reconocimiento o diferenciación de las cosas gracias a la experiencia o práctica del sujeto.
- **Conocimiento teórico.** Se refiere al conocimiento obtenido solo por teoría no siendo comprobable por la práctica.
- **Conocimiento Científico.** Es aquel que sigue un orden, jerarquización, progresión, capaz de ser comprobado y lograr predecir hechos. Se basan en la aplicación de un método lógico.
- **Conocimiento vulgar.** Adquirido durante la vida cotidiana por medio de la interacción del humano con la naturaleza. Presenta un carácter superficial, empírico y no sistematizado.
- **Conocimiento Popular.** Es aquel conocimiento de lenguaje sencillo, transmitido por el público en general sin una base científica.

3.2.1.2. Actitudes

El concepto de Actitud ha recibido diferentes definiciones por múltiples autores a través del tiempo, en este caso se mencionarán a algunos autores, como:

Lambert (1971 citado en Garzón 2014) quien afirma que las actitudes representan organizadamente la forma de sentir, pensar y reaccionar ante algún suceso, grupo de personas, etc. (33)

Morales (2000 citado en Montero 2018) refiere que la actitud es la predisposición aprendida, no innata y relativamente estable que valora de forma favorable o desfavorablemente un objeto que puede ser un individuo, grupo, situación, etc.(34)

las actitudes para Briñol, Falces y Becerra (2004) son evaluaciones globales con relativa estabilidad que las personas hacemos sobre objetos de actitud, es decir; sobre otras personas, cosas o ideas. Las actitudes hacen referencia al grado positivo o negativo con la que juzgamos aspectos de la realidad. Estas evaluaciones o juicios pueden ser positivas, negativas o neutras.(35)

Vallerand, (1994 citado en Ubillos) aporta algunas características centrales para las actitudes como: a) constructo o variable no observable directamente; b) es organizada porque se relaciona con aspectos cognitivos, afectivos y conativos; c) tiene un rol motivacional de impulsión y orientación a la acción y además influencia la percepción y el pensamiento; d) aprendida; e) perdurable; y f) presenta un componente de evaluación o afectividad de agrado o desagrado(36).

Como las actitudes representan un fenómeno mental, con una tendencia evaluativa no observable directamente desde fuera del propio sujeto, es necesario ciertos indicadores para poder inferir las actitudes de las personas. ES así, que; las actitudes presentan 3 componentes o dimensiones: Cognitivo, afectivo y conativo. (35)(34)

- **Componente Cognitivo.** Comprende los pensamientos, opiniones, creencias, valores, conocimientos y expectativas de carácter evaluativo acerca del objeto de actitud.
- **Componente Afectivo.** Engloba los sentimientos evaluativos y preferencias, estados de ánimo y emociones asociados al objeto de actitud (ansioso, feliz, preocupado, tenso, etc)
- **Componente Conativo o Conductual.** Incluye las intenciones o disposiciones a la acción, así como los comportamientos a favor o en contra hacia el objeto de actitud.

3.2.1.3. Prácticas

Según Paiva (2011 citado en Montero 2018) afirma que la práctica es sinónimo de acción desarrollada a partir de la aplicación de determinados conocimientos. Así mismo, refiere que la práctica puede ser entendida como experiencia, ya que, para poner en práctica cierto tipo de conocimiento se requiere de un primer acercamiento mediante contacto directo, percepción a través de los sentidos y una conducta psicomotriz. No pudiendo haber práctica tal cual sin previa obtención de experiencias. (34)

Para Florence Nightingale la experiencia, la observación y la reflexión son factores indispensables para las buenas prácticas.(37)

La práctica sobre las medidas de bioseguridad, representan a la aplicación de un conjunto de normas y procedimientos enfocados en la protección de la integridad física del personal de la salud ante riesgos biológicos, químicos y físicos (33). Para ello el profesional debe cumplir con actividades que implican el autocuidado como lavado de manos, uso de barreras de protección, adecuado manejo de los residuos y materiales contaminados y acciones que prevengan o eviten mayores daños ante los accidentes por exposición a sangre o fluidos corporales.

La práctica puede ser evaluada de forma objetiva por medio de la observación de las habilidades psicomotrices del sujeto, de forma independiente puede ser evaluada por conducta referida por el sujeto Según Paiva (2011 citado en Montero).(34)

3.2.2. Bioseguridad

La bioseguridad queda definida como un sistema de normas de acciones que regulan y orientan la práctica en salud, con el fin de satisfacer y responder las expectativas de cada una de las partes. (38)

La bioseguridad involucra una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad del personal de la salud, los pacientes, la comunidad y el medio

ambiente, frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos.(39)(40)

En la actualidad la Odontología se ha caracterizado por ser una de las profesiones más riesgosas, en el ámbito de la salud, de adquirir enfermedades infecciosas por agentes biológicos en el ambiente estomatológico, por tal motivo, los profesionales de esta área deben seguir meticulosamente las medidas de bioseguridad.(41)

3.2.2.1. Principios de bioseguridad

3.2.2.1.1. Universalidad

Las medidas incluyen a todos los pacientes, trabajadores y profesionales de todos los servicios sin excepción y se asume que toda persona puede presentar alto riesgo infeccioso a pesar de que no manifieste patologías. Así mismo, se considera que todo fluido corporal es potencialmente contaminante.(42)(43)

3.2.2.1.2. Uso de barreras

Implica evitar la exposición directa con sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes por medio de la utilización de materiales que se interpongan con estos.(42)

3.2.2.1.3. Medidas de eliminación de materiales contaminados

Corresponde al conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados, mediante los cuales, son depositados y eliminados sin riesgo los materiales y residuos de la atención con los pacientes.(42)

3.2.2.2. Protocolo de bioseguridad surgido en contexto de la COVID-19.

3.2.2.2.1. Recomendaciones previas a la recepción de pacientes

3.2.2.2.1.1. Establecimiento de las citas (14)

- Contactar al paciente mediante comunicación vía telefónica o virtual.
- Realización de un triaje para identificar el tipo de atención odontológica: urgencia, emergencia o teleconsulta.
- Aplicación de un cuestionario de triaje para Covid-19, teniendo en cuenta poblaciones vulnerables, incluidas las gestantes.
- De encontrar un paciente sospechoso de Covid-19 durante el cuestionario, este deberá ser notificado a la DIRIS, DIRESA O DIGESA.
- En los pacientes que su tratamiento fue interrumpido debido a la emergencia sanitaria, se contactará por vía telefónica o virtual para el seguimiento e identificación de la necesidad de atención.
- Las citas se programan con anticipación y serán cumplidas estrictamente en el horario establecido para evitar aglomeraciones en la sala de espera.
- Si el paciente acude sin cita previa, se debe realizar triaje y aplicar cuestionario para identificar el tipo de atención que requiera, y a la vez su atención inmediata o reprogramación.
- Se indicará al paciente no acudir acompañado en la medida posible.

3.2.2.2.1.2. Disposiciones en la sala de Espera (14)(15)(44)(45)

- Retirar cualquier objeto no indispensable que incremente la contaminación y dificulte la limpieza dentro del ambiente de espera: revistas, juguetes, macetas, floreros, cuadros decorativos, etc.
- Disponer de un cartel informativo de fácil visibilidad que ilustre las recomendaciones para el paciente.

- Se debe contar con ventilación natural dentro de la sala de espera y omitir aire acondicionado.
- Contar con dispensadores de alcohol en cualquier presentación, así como de toallas de papel desechables que puedan contener secreciones al estornudar o toser las cuales serán desechadas en tachos respectivos.
- Limpiar y desinfectar los lugares de atención con el paciente y superficies que frecuentemente son manipuladas (manijas de puertas, mobiliarios, escaleras, barandas, etc.)

3.2.2.2.1.3. Disposiciones en los Servicios Higiénicos (14)(15)

- Disponer de insumos como jabón líquido antibacterial y toallas de papel necesarios para el lavado de manos.
- Retirar cualquier elemento decorativo e innecesario para facilitar la limpieza y desinfección.
- Disponer de cartel que ilustre los pasos y técnica del lavado de manos.
- Limpiar y desinfectar con hipoclorito de al 0.1% diariamente las superficies de los servicios higiénicos: grifos, dispensadores, inodoro, manijas de puertas, etc.
- Queda prohibido cepillarse los dientes o las prótesis dentales en los servicios ya que aumentaría el riesgo de contagio.

3.2.2.2.2. Recomendaciones durante la recepción de pacientes (45)(14)

- Todo paciente y/o acompañante deberá acudir a la hora indicada de su cita y portará por lo menos una mascarilla quirúrgica.
- Se debe monitorear la temperatura de todo paciente que ingrese.
- Se mantendrá un distanciamiento social mayor a 1 metro, el COP y Essalud recomiendan que sean 2 metros.

- Destinar un bolígrafo a cada trabajador y uno solo para los pacientes, este será desinfectado después de cada uso.
- Evitar el uso de papelería. Lavarse las manos en caso de coger la tarjeta de atención del paciente.
- Indicar al paciente que lave sus manos con agua y jabón antes y después de la atención.

3.2.2.2.3. Recomendaciones previas a la atención de pacientes

3.2.2.2.3.1. Lavado de manos

El lavado de manos representa a la medida más económica, sencilla y eficaz en la disminución de riesgos contra infecciones.(46) Altera la flora residente y elimina la flora transitoria de la piel y uñas, disminuyendo así, la carga y transmisión de microorganismos de un ser a otro.(43)

Según la OMS establece indicaciones para el lavado, la desinfección y los 5 momentos clave del lavado de manos:(47)(48)

- Lavado de manos con jabón: cuando las manos están sucias, la duración del procedimiento es de 40-60 segundos.
- Desinfección de manos con alcohol (60-80%): Cuando las manos no están muy sucias, frotarlas durante 20-30 segundos.
- Los 5 momentos para el lavado de manos comprenden: Antes de tocar al paciente, antes de realizar alguna tarea limpia/aséptica, después de exponerse a fluidos corporales, después de tocar al paciente y después de tener contacto con el entorno del paciente.
- Todo profesional de salud bucal se debe realizar siempre la higiene de manos con agua y jabón por un tiempo de 1 minuto como mínimo, antes y después de la atención de cada paciente, después de tener contacto con superficies o equipos contaminados y después que se retire el EPP(44). Así mismo, se pide al paciente asear sus manos a su llegada y durante su estadía (48)
- El profesional evitará tocarse la boca, nariz y ojos sin antes haberse lavado las manos.

3.2.2.3.2. Disposiciones para el uso de EPP(14)(44)

El equipo de protección personal (EPP), se refiere a la indumentaria que ha sido diseñada para proteger al personal de salud ante la exposición o contacto con fluidos potencialmente infecciosos como saliva, sangre y otros.

Es importante que el profesional se encuentre capacitado con respecto al uso de EPP, puesto que estas acciones son clave para mitigar la infección cruzada en los ambientes clínicos odontológicos.

Indicaciones antes del uso de EPP (14)(44)

- El equipo de profesionales en salud bucal debe evitar el uso de accesorios como relojes, anillos, pulseras u otros objetos que pueden ser reservorios de microorganismos y además que podrían dificultar la colocación de los EPP. Así mismo, de presentar cabello largo, este debe estar bien atado de modo que no se desplace por el rostro.
- El EPP deberá ser utilizado al inicio y durante la realización de procedimientos operatorios, para luego ser desechado en una bolsa roja en la misma área del procedimiento. Este equipo consta de los siguientes elementos:
 - Respiradores o mascarillas con >95% de eficiencia de filtrado sobre todo en procedimientos generadores de aerosoles. Se debe verificar que el respirador se encuentre íntegro y en buen estado.
 - Mameluco o mandilón descartable e impermeable ante fluidos
 - Protector ocular o facial antiempañantes. Los protectores faciales deben cubrir desde la frente hasta el mentón y los costados.
 - Guantes de látex desechables
 - Gorro y protector de calzado desechables.
- Todo paciente que requiera atención deberá utilizar un campo descartable obligatoriamente. Siendo opcionales, los lentes y el gorro.

Indicaciones para la colocación del EPP

Según el MINSA(14), establece una secuencia correcta para la colocación de los EPP, que a continuación se detalla:

- a) Colocación del Mandilón:** Debe cubrir el torso desde el cuello hasta las rodillas, y en los brazos hasta la muñeca. Hacer un dobléz a la altura de la espalda y atar a nivel del cuello y la cintura.
- b) Colocación del gorro.** Con el cabello recogido y atado, colocar el gorro asegurando que este cubra completamente la cabellera. Finalmente, si el gorro tuviese cintas estas se atan firmemente asegurando que el gorro no se desplace o caiga.
- c) Colocación del respirador (filtro > 95%)** Sostener el respirador en la palma de la mano dejando que las cintas cuelguen libremente. Luego colocarlo en la barbilla teniendo en cuenta que la pieza nasal debe estar hacia arriba. En seguida llevar las cintas hacia atrás de la cabeza, la cinta inferior se posiciona a nivel de la parte inferior de la cabeza cerca al cuello y la cinta superior a nivel de la mitad de la cabeza. Finalmente colocar los dos dedos de cada mano (índice y dedo medio) sobre la nariz para ajustar el respirador.
- d) Colocación del protector ocular o facial.** Colocarse los lentes protectores asegurando que estos no queden sueltos. De no contar con lentes protectores, usar el protector facial ajustándolo en la parte posterior.
- e) Colocación de guantes**
Colocarse los guantes y extenderlos hasta que cubran el puño del mandilón.

3.2.2.2.4. Recomendaciones durante la atención estomatológica (44)(45)

Con la finalidad de controlar la infección por Covid-19 la OMS recomienda atender casos de urgencia-emergencia, por lo cual las diversas instituciones como MINSA, COP, Essalud, COL, etc, lo sugieren.

3.2.2.2.4.1. Urgencia Odontológica

La urgencias dentales o estomatológicas corresponden a aquellas afecciones que necesiten atención inmediata para aliviar el dolor severo y/o riesgo de infecciones.

3.2.2.2.4.2. Emergencia Odontológica

Corresponden a aquellas situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente, en tal sentido el paciente deberá ser atendido de manera inmediata o ser referidos a centros con suficiente capacidad resolutive para su tratamiento.

3.2.2.2.4.3. Examen Estomatológico (44)(14)

- Al momento de realizar la historia clínica, el profesional deberá estar a 2 metros de distancia y portar equipo de protección personal.
- Par el diagnóstico imagenológico, se utilizarán radiografías extraorales y/o tomografías. Evitando el uso de radiografías intraorales.

3.2.2.2.4.4. Procedimientos Estomatológicos (45)(44)(48)(14)

- Si un paciente presenta sintomatología sospechosa o confirmada de Covid-19, se debe posponer el tratamiento de urgencia. De requerir tratamiento de emergencia se realizará en salas de aislamiento con presión negativa y bien acondicionados.
- Se recomienda el trabajo a cuatro manos con el fin de disminuir el tiempo clínico y evitar manipulación excesiva del material.
- Utilizar un enjuague bucal de peróxido de hidrógeno al 1% por 1 minuto o yodopovidona 0.2% por 20 segundos, para disminuir la carga bacteriana o viral.
- Utilizar dique de goma durante los procedimientos, para minimizar salpicaduras de saliva por el paciente.

- Emplear succión de alta potencia para disminuir la emisión de aerosoles, así mismo, se debe evitar que el paciente escupa en la escupidera.
- En caso se contamine la mascarilla quirúrgica con fluidos de sangre, saliva del paciente, esta será desechada inmediatamente.
- Ante tratamientos restauradores: Deben adoptar preferentemente técnicas mínimamente invasivas que no emitan aerosol, pudiendo utilizar ionómeros de vidrio, flúor diamino de plata, entre otros.
- Ante procedimientos quirúrgicos de baja complejidad se debe preferir el uso de suturas reabsorbibles y soluciones salinas estériles como irrigantes.
- Los tratamientos pulpares o endodónticos, se realizarán bajo aislamiento absoluto y se utilizará como irrigantes soluciones de hipoclorito de sodio al 1%.
- Ante tratamientos periodontales y gingivales, se debe preferir el uso de instrumentos manuales de retiro y remoción de placa, limitando el uso del ultrasonido.
- En tratamientos de rehabilitación protésica, se debe evitar inducir a reflejos nauseosos y de tos, para ello asegurarse de succionar fluidos y verificar que la cubeta sea adecuada.

3.2.2.2.5. Recomendaciones posteriores a la atención estomatológica

3.2.2.2.5.1. Retiro de EPP

El retiro de cada componente del EPP debe hacerse con mucho cuidado puesto que la parte externa está completamente contaminada. Así mismo, una vez retirado todo el EPP se procede al inmediato lavado de manos(14). Según el MINSA sugiere una secuencia de retiro del EPP que a continuación se detalla.

- a) Retiro de guantes:** Tomar la parte exterior del guante con la mano opuesta y retirárselo con cuidado. Luego con la mano enguantada sostener el guante quitado. Deslizar los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante a nivel de la muñeca y quitar el guante de modo

que acabe cubriéndolo al primer guante. Finalmente arrojar los guantes en el recipiente de desechos.

- b) Retiro del protector ocular o facial:** Sostener por la parte de las orejas o la banda posterior y quitárselo, colocarlo en un recipiente designado para el procesamiento de materiales o de desecho.
- c) Retiro del mandilón.** Desatar los cordones, tacando solamente la parte interna del mandil pasarla hacia adelante por encima de los hombros y el cuello. Retirarla volteándola hacia el lado reverso, doblar y enrollar para su desecho final.
- d) Retiro del respirador:** Tener en claro de no tocar la parte anterior del respirador. Tomar desde los cordones o cintas posteriores y quitarse el respirador sosteniéndolo por los cordones. Finalmente desecharla en el recipiente para desechos.
- e) Retiro del gorro descartable** Desajustar la parte posterior y desecharlo

3.2.2.2.5.2. Limpieza, desinfección y esterilización

La limpieza corresponde a la remoción mecánica de aquella materia extraña en el ambiente, superficies y objetos, por medio de lavado manual o mecánico con el objetivo de disminuir el número de microorganismos. Se suele usar para ello agua y detergente, preferentemente detergente enzimático para garantizar la eficacia del proceso.(49)(14)

La desinfección es el proceso por el cual se logra eliminar a los microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados mediante métodos químicos y físicos, sin llegar a eliminar las esporas bacterianas y los virus (49)(43)(14). El grado de desinfección depende de factores como: calidad y concentración del agente microbiano, naturaleza de la contaminación de los objetos y el tiempo de exposición.(43)

La desinfección implica tres categorías de acuerdo al nivel de eficacia de la desinfección:(14)

- Nivel alto de desinfección (DAN): Elimina a todo microorganismo (bacterias, hongos, virus, esporas por medio de agentes químicos líquidos como:

ortoftaldehído, glutaraldehído, ácido peracético, dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno y el formaldehído.

- Nivel intermedio de desinfección (DIN): Eliminan algunas bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas, utilizando agentes químicos como: fenoles, hipoclorito de sodio, cetrimida y cloruro de benzalconio.
- Nivel bajo de desinfección (DBN): Se logran eliminar bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en tiempos cortos menores a 10 minutos, mediante agentes químicos del grupo amoniocuaternario.

La esterilización es el proceso mediante el cual se eliminan todas las formas vivientes (microorganismos, incluidas esporas) de los instrumentos u objetos inanimados, logrando la protección antibacteriana de los instrumentos y materiales. (43) El proceso de esterilización constituye una secuencia de pasos: remojo del instrumental con agua y detergente enzimático, limpieza, secado, empaquetado, esterilización, almacenaje y distribución.(50)

Existen 3 factores importantes al momento de esterilizar en una autoclave: la presión, la temperatura y el tiempo.

Presión (Atm)	Temperatura	Tiempo de exposición
1,5	121° C	15'
2,0	126° C	10'
2,9	134° C	3'

FUENTE: Ministerio de Salud Chile “Normas Técnicas sobre Esterilización y Desinfección de Elementos Clínicos” 2001.

De los dispositivos médicos de atención estomatológica (14)

- Se debe considerar las instrucciones del fabricante al momento de descontaminar instrumentos, equipos dentales y dispositivos médicos.
- Se deberá cumplir estrictamente con las normas establecidas y secuencia para la limpieza, desinfección y esterilización aprobadas por el MINSA en el Manual de Desinfección y Esterilización-2002.

- El personal de salud bucal deberá identificar y clasificar a los dispositivos en críticos, semi críticos y no críticos para un manejo adecuado. (ANEXO N°14)
- Las piezas de mano, motores de baja velocidad, contra ángulos, o dispositivos reutilizables fácilmente pueden contaminarse con fluidos orales del paciente por lo que deben esterilizarse según instrucción del fabricante, y los que no pueden esterilizarse por calor no serán utilizados. Tampoco se debe usar algún nivel de desinfección.
- Para garantizar la eficacia de la limpieza se debe utilizar detergente enzimático.
- Los instrumentos una vez secos, serán inspeccionados, envueltos, empacados, etiquetados y colocados en contenedores antes de ser sometidos a calor húmedo o seco.
- Los instrumentos estériles serán almacenados en gabinetes cerrados y antes de su uso serán inspeccionados para asegurar que no estén contaminados (mojado, roto, perforado).

De las superficies del servicio estomatológico

- Antes de desinfectar cualquier superficie se debería realizar la limpieza.
- Usar barreras de protección como envolturas de plástico transparente, tubos u otros materiales impermeables, para cubrir aquellas superficies clínicas de fácil contaminación y aquellas que sean difíciles de limpiar, estas barreras deberán removerse y descartarse entre un paciente y otro.
- Para el uso de limpiadores y desinfectantes se debe seguir las instrucciones del fabricante (diluciones según cantidad, tiempo de contacto, eliminación).
- Para la desinfección de superficies se cuenta con los siguientes agentes:
 - Etanol 62% - 71%
 - Peróxido de hidrógeno 0.5%
 - Hipoclorito de sodio al 0.1%

Limpieza, desinfección para la reutilización de algunos elementos del EPP en situaciones de escasez.

- Los mandilones o batas de tela se lavarán en máquinas a temperatura de 60°C a 90°C, de no ser posible este método, serán remojadas con agua caliente y jabón en una tina grande, luego remojarlas por 30 minutos con solución de hipoclorito de sodio al 0.05%, enjuagarlas con agua y finalmente dejar secar por completo al sol.(14)
- Los protectores faciales reutilizables y los lentes protectores, inmediatamente después de cada atención odontológica deberán ser lavados con agua y jabón o detergente, seguidamente serán desinfectados con alcohol al 70% o hipoclorito de sodio al 0.1% durante 10 minutos (para luego enjuagar con agua limpia), y finalmente ser guardados en una zona limpia para evitar su contaminación.(45)(14)
- Los respiradores N95, FFP2 o equivalentes, pueden resistir usos prolongados de 8-12 horas como máximo, y ante situaciones extremas de escasez pueden usarse más de una vez, no superando los cinco (05) usos como máximo, para ello se deben seguir procesos de descontaminación o se debe instruir al personal sobre acciones para reducir la transmisión de contactos con el respirador. Se recomienda que el uso del respirador sea estrictamente personal, se debe seguir el lavado de manos antes y después de ajustar o tocar el respirador, nunca tocar la parte interna del respirador, utilizar sobre los respiradores protectores faciales, para su reutilización deberán ser colgados en áreas de almacenamiento destinados o introducidos en recipientes limpios y transpirables como bolsas de papel desechables y finalmente ser rotulados con nombre y apellido.(51)

3.2.2.2.5.3. Manejo y eliminación de residuos (14)(44)

- El manejo de los residuos para su eliminación debe seguir la Normativa técnica de Salud “Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud, Servicios Médicos de Apoyo y Centros de Investigación”.
- Los residuos se colocarán en sus respectivas bolsas: residuos biocontaminados-bolsa roja, residuos comunes-bolsa negra y residuos especiales-bolsa amarilla.
- Las mascarillas quirúrgicas y los respiradores contaminados con sangre, secreciones o fluidos, que hayan perdido su capacidad de ajuste, que hayan sido aplastados accidentalmente, etc serán eliminados en una bolsa roja,
- Los elementos del EPP descartables como mandilones, gorros, botas, mascarillas y protectores y todo residuo generado en la sala de procedimiento odontológico serán descartados en bolsas rojas.
- Se debe evitar contaminar la parte exterior de la bolsa al momento de depositar los residuos, de suceder esto, se deberá cubrir esta con otra bolsa roja o desinfectar el exterior de bolsa antes de retirarla del consultorio.
- Los residuos punzocortantes se colocarán en contenedores rígidos, descartables y rotulados. Los contenedores serán descartados al cumplir el límite de su capacidad de llenado (3/4 partes del recipiente).
- Se utilizarán guantes descartables para el transporte de residuos fuera de la sala de procedimientos.

Residuos Punzocortantes (43)

Los elementos punzocortantes incluyen: agujas, bisturíes, curetas de dentina y periodontales, exploradores, fresas diamantadas y de carburo, instrumentos de endodoncia, bandas y alambres de ortodoncia, etc. Se debe tener en cuenta que existen altos porcentajes de accidentes laborales por seguir un mal manejo de estos residuos.

Para la manipulación de los residuos punzo-cortantes se debe considerar:

- Nunca reinsertar las agujas con su protector con las manos, sino utilizar una pinza porta aguja. Además el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH y CDC) prohíbe volver a tapar las agujas contaminadas.(52)
- Nunca colocar las agujas sin cubierta en la bandeja de instrumentos.
- Las agujas que no tengan cubierta se retirarán utilizando pinzas porta agujas y serán colocadas en contenedores.
- No se deben doblar las agujas ni intentar romperlas.
- Las hojas de bisturí serán retiradas del mango con instrumentos que presenten cremalleras.
- El pase de instrumentos punzocortantes entre asistente y operador deberá conseguir una coordinación precisa, de lo contrario solo el operador podrá manipularlo.
- Las agujas y hojas de bisturíes serán colocados en contenedores rígidos que resistan la punción, estando estos ubicados en lugares próximos al área de trabajo.

3.2.2.3. Medidas de bioseguridad frente a accidentes de exposición a sangre o fluidos corporales (AES).

Las AES corresponden a cualquier contacto con sangre o fluidos corporales por medio de una solución de continuidad (pinchazo, herida cortante), salpicaduras hacia la conjuntiva ocular, mucosas o piel lesionada.(43) (11)

En la práctica odontológica existen diversos agentes que se transmiten por las AES, siendo los más frecuentes el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el virus de la hepatitis B (HVB) y de la hepatitis C (HVC). Las enfermedades menos frecuentes pero que por ello no dejan de ser importantes son las siguientes: tuberculosis, herpes simple tipo I y tipo II, etc.(43)

Según los estudios indican que los procedimientos de exposición más importantes en la odontología corresponden a la eliminación de agujas o

instrumentos, la asistencia durante la suturas, la inyección de anestésicos, uso de jeringas, uso de fresas y la limpieza del instrumental.(11)

3.2.2.3.1. Riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas por AES

Para la valoración del riesgo se debe tener en cuenta factores dependientes al tipo de exposición y aquellos que tienen relación directa con el accidente. (53)

En el caso de VIH, la exposición percutánea resulta ser la más eficiente para su transmisión que la transmisión por mucosas.

En cuanto a los factores relacionados al accidente se conoce que la transmisión dependerá de: la profundidad del pinchazo (a mayor profundidad mayor riesgo), el tipo de material como por ejemplo una aguja hueca o aguja maciza o bisturí (el riesgo va a aumentar de forma concomitante conforme aumenta el diámetro de la aguja), factor barrera (usar guante disminuye el 50% del volumen inyectado), tipo y condición del epitelio (la piel sana es una excelente barrera y presentará poco riesgo).

Por último, el riesgo de transmisión de VIH, VHB y VHC en una exposición ocupacional va a depender del tipo de fluido al que se exponga el profesional.

Según estudios, ante una exposición percutánea a sangre el riesgo de transmisión del VIH es del 0.3%. Con respecto a otros fluidos aún no se conoce con exactitud, pero se asume que es inferior al contacto con sangre. La exposición percutánea ante una fuente positiva de VHC tiene un riesgo promedio de 1.8 %. El riesgo de adquirir la infección por VHB en el personal no vacunado luego de una exposición percutánea con sangre va a depender de ciertos marcadores en el paciente fuente, si el antígeno de superficie para la hepatitis B (HBs Ag) es positivo y el antígeno para el virus de la hepatitis B (HBe Ag) es positivo el riesgo de transmisión es al menos del 30%, mientras que si el antígeno para el virus (HBe Ag) es negativo el riesgo es menor al 6%.(53)

3.2.2.3.2. Conductas por seguir ante un AES. (43)(54)

3.2.2.3.2.1. Cuidados de urgencia

a. En casos de pinchazos y heridas

- Retiro de guantes
- Lavar de inmediato la zona lesionada con abundante agua y jabón.
- Realizar antisepsia de la lesión con alcohol al 70% o alcohol yodado durante 3 minutos.
- Según la extensión de la herida cubrirla con gasa estéril.
- Mantener cubierta la herida al momento de atender pacientes hasta que cicatrice completamente.

b. En casos de contacto con mucosas (ojos, nariz y boca)

- Hacer lavado profuso con agua o suero fisiológico durante 10 minutos como mínimo.
- No se deben utilizar desinfectantes sobre las mucosas.
- En contacto con los ojos se recomienda añadir colirio simple.

c. En casos de contacto con piel intacta

- Realizar arrastre mecánico con agua corriente por lo menos durante 10 minutos.

3.2.2.3.2.2. Cuidados posteriores a la urgencia

Para continuar con la ruta a seguir ante un AES se deben realizar los siguientes pasos en el orden que se detallan:

- Comunicar de inmediato al supervisor designado por cada institución, el cual debe realizar la evaluación del tipo de riesgo que ha generado el accidente.

- En casos que le correspondan los beneficios y prestaciones de los seguros, será enviado inmediatamente al mismo para proseguir con las medidas a tomar.
- Cada institución deberá disponer en todo momento la medicación para dar inicio al tratamiento.
- Protocolo Sanitario. Consiste en la extracción inmediata de una muestra de sangre para los test de Hepatitis B, C y VIH que se repetirá al 1,3,6 y 12 meses.(54)
 - ✓ En casos de VIH iniciar medicación de inmediato en lo posible dentro de las primeras horas y máximo dentro las 72 horas de la exposición. En los casos de Hepatitis B y C seguir procedimientos de actuación lo antes posible y siempre antes de las 96 horas.(53)
 - ✓ El supervisor solicita voluntariamente al accidentado los exámenes serológicos correspondientes (a realizar dentro de las 24 horas de producido el accidente). En ningún caso el inicio de la medicación será retrasada por dichos exámenes.
 - ✓ Es necesario conocer el estado clínico-serológico del paciente fuente. De ser desconocido, el médico prescribirá con previo consentimiento del paciente los siguientes exámenes: serología para VIH (a realizar urgentemente preferible dentro de las 2 primeras horas), marcadores de hepatitis B, C y otros análisis que el médico crea oportuno. En casos que no se pueda evaluar al paciente fuente, este será considerado como positivo y procederse en consecuencia.
- Complementar con el llenado del formulario de declaración de accidente laboral, el cual se adjunta y archiva en la institución pública o privada.
- Se notifica el accidente a los Comités Locales de Control de Infecciones del establecimiento de salud.
- A las 48 horas el médico de referencia reevaluará toda la situación teniendo en cuenta lo siguiente: presencia de indicadores de riesgo de la infección, el conocimiento de la serología del paciente fuente y la tolerancia a la medicación.

Con estos datos se evaluará la pertinencia de la continuación del tratamiento iniciado o su interrupción en caso de no ser justificado.

3.2.2.3.3. Profilaxis Post Exposición (PPE)

La profilaxis posterior a la exposición es una estrategia biomédica que previene la transmisión de enfermedades transmitidas por sangre luego de una posible exposición al VIH, VHB, VHC, entre otros. Su inicio recomendable de la PPE debe ser lo antes posible (dentro de las 6 horas posteriores) incluso cuando no se cuenten con los exámenes de laboratorio y no debe tardarse luego de las 72 horas. La PPE se suspenderá cuando se tengan resultados negativos y así evitar efectos secundarios. Si bien la PPE no puede prevenir la infección, sin embargo, puede limitar la replicación del virus evitando que el ADN viral se incorpore al ADN del huésped.(53)(13)

3.2.2.3.3.1. Procedimiento de actuación ante casos de VIH. (54)

- ✓ Si la serología del paciente fuente es negativa: el trabajador no requiere seguimiento.
- ✓ Si la serología del paciente fuente es positiva: Iniciar profilaxis Post Exposición (PEP) inmediatamente, de preferencia dentro de las 2 primeras horas y como máximo 72 horas. La PEP consiste en una terapia triple a base de retrovirales, con una duración de 4 semanas.
- ✓ El seguimiento del profesional accidentado consiste en nuevas serologías a las 6 semanas, 3 y 6 meses. En casos que hubiese coinfección con VHC se prolongará hasta los 12 meses.

3.2.2.3.3.2. Procedimiento de actuación en casos de Hepatitis B. (43)(54)

Se debe aplicar inmunoglobulinas y vacunas según sea el caso (ANEXO N°13). El seguimiento serológico se determina mediante la determinación de AgHBs y antiHBs a las 3 semanas, 3 y 6 meses luego de la exposición.

3.2.2.3.3.3. Procedimiento de actuación en casos de Hepatitis C.(54)

No existe una profilaxis efectiva en los casos de Hepatitis C, debido a que, para que el tratamiento sea eficaz ya debe existir una infección establecida. Por lo que en estos casos es importante el seguimiento y así poder diagnosticar lo antes posible una infección aguda de VHC en donde el tratamiento puede ser más eficaz.(53)

- ✓ Si la serología del paciente fuente es negativa en VHC: El trabajador no requiere seguimiento.
- ✓ Si la serología del paciente fuente es positiva o falsa negativa: se recomienda la realización del RNA-VHC.
- ✓ Si el paciente fuente es positivo en VHC. Realizar seguimiento serológico a las 6 semanas, 3 y 6 meses luego de la exposición.
- ✓ Si el paciente fuente presenta coinfección de VHC- VIH, el seguimiento del trabajador se prolongará hasta los 12 meses.

Se conoce que la mayoría de los accidentes ocurren por pinchazos con objetos punzocortantes, los estudios recomiendan que se debe utilizar la técnica de doble guante al realizar procedimientos quirúrgicos, ya que el uso de doble guante podría reducir la tasa de perforaciones de los guantes quirúrgicos y a la vez reduciría el riesgo de la infección cruzada por patógenos transmitidos por la sangre. (55)

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

3.3.1. Conocimiento.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua española define al conocimiento como la acción y efecto de conocer, entendimiento, inteligencia, noción, saber o noticia elemental de algo. (56)

3.3.2. Actitudes

La actitud se refiere a la forma de actuar de un individuo, así como también al comportamiento que emplea para realizar sus labores. Según Morales (2000), afirma que la actitud es la predisposición aprendida, no innata y estable, aunque puede cambiar, a reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable ante un objeto (individuo, grupo, situación, etc.)

3.3.3. Práctica

La Real Academia Española define a la práctica como dicho conocimiento que enseña el modo de hacer algo, el ejercicio de cualquier arte o facultad conforme a sus reglas, así mismo, la define como la destreza adquirida por el ejercicio de la práctica.

Según Mayorca (2010) afirma que “la práctica es el conjunto de destrezas y/o habilidades adquiridas por medio de la experiencia, la cual puede ser valorada a través de la observación o puede ser referida y/o expresada a través del lenguaje”

3.3.4. Bioseguridad:

Según Papone (2000) nos menciona que la bioseguridad debe ser entendida como una doctrina de comportamientos cuya finalidad es lograr actitudes y conductas que reduzcan el riesgo del personal de la salud en adquirir infecciones en su medio de trabajo, y que a la vez comprenden a todas aquellas personas que se encuentren en el ambiente asistencial.

3.3.5. Fuente:

Persona, objeto o sustancia desde la cual un agente infeccioso puede lograr transmitirse hacia una persona expuesta.

3.4. HIPÓTESIS

La presente investigación no cuenta con hipótesis.

Variables

- ✓ **Variable 1:** Nivel de conocimiento sobre normas de bioseguridad
- ✓ **Variable 2:** Nivel de actitudes sobre normas de bioseguridad
- ✓ **Variable 3:** Nivel de prácticas sobre normas de bioseguridad

Covariables:

- Edad
- Sexo
- Distrito
- Experiencia profesional

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES	DEFINICIÓN	DIMENSIONES		INDICADORES	VALORES	ESCALA	INSTRUMENTO
Nivel de conocimientos sobre las medidas de bioseguridad	Información teórica adquirida sobre las medidas de bioseguridad en la atención odontológica para evitar infecciones transmisibles en la práctica odontológica	Generalidades de las enfermedades infecciosas transmisibles en la consulta Odontológica		Modos de transmisión	Bueno (13-16) Regular (9-12) Malo (0-8)	Cuantitativa a intervalo	Cuestionario
		Barreras de Protección		Lavado de manos			
		Manejo y eliminación de residuos		Uso de EPP			
				Procesamiento, desinfección y esterilización.			
		Medidas ante accidentes de exposición a sangre y fluidos corporales		Manejo y eliminación de residuos			
				Medidas básicas ante las AES			
Actitudes frente a las medidas de bioseguridad	Manera o forma de pensar, actuar o reaccionar del odontólogo frente a las medidas de bioseguridad.	Componente cognitivo	Transmisión de infecciones	Opiniones	Escala de líkert Positivo (59-75) Neutro (42-58) Negativo (15-41)	Cuantitativa a intervalo	Cuestionario
			Uso de barreras de protección				
			Manejo y eliminación de residuos				
			Medidas ante accidentes de exposición a sangre y fluidos corporales				

Prácticas sobre las medidas de bioseguridad	Procedimientos, reglas y políticas que el profesional debe implementar en su praxis diaria para evitar la infección cruzada	Barreras de protección	Uso de barreras de protección	Bueno (32-42) Regular (22-31) Malo (14-21)	Cuantitativa a intervalo	Cuestionario
		Manejo y eliminación de residuos	Manejo y eliminación de residuos			
		Medidas ante accidentes de exposición a sangre y fluidos corporales	Medidas ante accidentes de exposición a sangre y fluidos corporales			
Covariable Sexo	Característica física y sexual que distingue al varón de la mujer.	Características Físicas	Auto reporte del participante (Tipos)	Femenino Masculino	Cualitativa nominal	Cuestionario
Covariable Edad	Tiempo que ha vivido una persona desde su nacimiento.	Tiempo de vida en años	Auto reporte del participante (años cumplidos)	20-30 años 31-40 años 41 a más años	Cuantitativa a Razón	Cuestionario
Covariable Distrito	Distrito de Lima Metropolitana de la DIRIS Lima Centro donde el odontólogo ejerce su profesión.		Auto reporte del participante		Cualitativa nominal	Cuestionario
Covariable Años de experiencia profesional	Tiempo transcurrido desde la titulación del odontólogo para ejercer activamente su carrera profesional.	Tiempo transcurrido en años	Auto reporte del participante	0-5 años 6-10 años 11años a más	Cuantitativa a de razón	Cuestionario

4. METODOLOGÍA

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación corresponde a un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal.

Descriptivo porque busca describir y caracterizar a las variables, sin establecer relaciones causales.

Transversal porque se desarrollará en un solo periodo de tiempo o momento.

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

4.2.1. POBLACIÓN

La población estará conformada por los odontólogos que se encuentren laborando en las IPRESS públicas del Nivel I de atención de la DIRIS Lima Centro, aproximadamente 150 odontólogos.

4.2.2. MUESTRA

Mediante muestreo probabilístico aleatorio, con la aplicación de la fórmula para poblaciones finitas.

$$n = \frac{Z^2 \cdot p_e \cdot q_e}{E^2} \qquad n = \frac{n}{1 + \frac{n}{N}}$$

Donde:

- Nivel de confianza del 95%: $Z = 1.69$
- p : 0.5
- q : $1-p = 0,5$
- Error absoluto al 5%: $E = 0.05$
- N : Población= 150

La muestra queda definida por 108 participantes.

4.2.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Odontólogos titulados, colegiados y habilitados.
- Odontólogos generales y especialistas.
- Odontólogos con o sin vínculo laboral con la DIRIS Lima Centro.

4.2.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Odontólogos que no firmen el consentimiento informado.
- Odontólogos que no completen los cuestionarios.

4.2.2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS

Odontólogo de la IPRESS pública de la DIRIS Lima Centro.

4.3. TÉCNICA, PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se desarrollará mediante la metodología de encuesta con la aplicación de cuestionarios.

Se utilizará un cuestionario para determinar el nivel de conocimientos de los odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas Lima Centro sobre las medidas de bioseguridad (ANEXO N°1). El cuestionario está dividido en 4 partes: generalidades de las enfermedades infecciosas, barreras de protección, manejo y eliminación de residuos y accidentes de exposición a sangre o fluidos corporales. Se incluyen en total 16 preguntas de tipo de selección de respuesta correcta con 4 alternativas de respuesta.

Por respuesta correcta se dará una puntuación de 1 y según la sumatoria total de puntuaciones se establecerán a los conocimientos como: Buenos (13 – 16 puntos), regulares (9 – 12 puntos) y malos (0 – 8 puntos).

La validación de contenido del cuestionario para evaluar el nivel de conocimientos se realizó mediante juicio de expertos (5 expertos en el área) (ANEXO N° 2). Se obtuvo una V de Aiken de 0.98, 1, 0.99 y 0.97 para los criterios de claridad, coherencia, relevancia y suficiencia respectivamente. (ANEXO N° 3) indicando que el cuestionario es válido significativamente.

Para identificar las actitudes de los odontólogos sobre las medidas de bioseguridad se utilizará un cuestionario (ANEXO N° 4) dividido en 4 dimensiones: Transmisión de infecciones, Uso de barreras de protección, Manejo y eliminación de residuos y Medidas ante accidentes de exposición a sangre y fluidos corporales. En total se incluye 15 ítems y utilizando la escala likert se valorará a cada ítem con valores del 1-5:

- Totalmente en desacuerdo: 1
- En desacuerdo: 2
- Indiferente: 3
- De acuerdo: 4
- Totalmente de acuerdo: 5

Según la puntuación total obtenida se establecerán a las actitudes como: Positivas (59-75 puntos), Neutras (42-48 puntos) y Negativas (15-41 puntos).

La validación de contenido del cuestionario para evaluar las actitudes se realizó por medio de juicio de expertos (5 expertos en el área) (ANEXO N° 5). Según la prueba V de Aiken se obtuvieron valores de 0.98, 0.97, 0.97 y 1 para los criterios de claridad, coherencia, relevancia y suficiencia respectivamente. (ANEXO N° 6) Indicando una adecuada validez del cuestionario.

Con respecto a la evaluación de las prácticas de los odontólogos, se utilizará un cuestionario de aproximadamente 14 ítems, distribuidos en 3 dimensiones: Uso de barreras, Manejo y eliminación de residuos y Medidas ante accidentes de exposición a sangre y fluidos corporales (ANEXO N° 7) Cada ítem será valorado del 1-3

- Nunca: 1
- A veces: 2
- Siempre: 3

Según la puntuación total obtenida y se establecerán a las prácticas como: Buenas (32 - 42 puntos), regulares (22 – 31 puntos) y malas (14 – 21 puntos).

La validación de contenido del cuestionario para evaluar las prácticas se realizó por medio de juicio de expertos (5 expertos en el área) (ANEXO N° 8). Según la prueba V de Aiken se obtuvieron valores de 1 para todos los criterios (claridad, coherencia, relevancia y suficiencia) (ANEXOS N° 9). Lo cual indica que el cuestionario es significativamente válido.

4.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Luego de la aplicación del instrumento se realizará el análisis estadístico tanto descriptivo como inferencial a través del procesamiento de la base de datos utilizando el programa estadístico del SPSS versión 25.

Se utilizará estadística descriptiva que incluye porcentajes, media y DE de las puntuaciones. Las puntuaciones se estratificarán en categorías buenas, regulares y malas y se evaluarán las correlaciones entre las puntuaciones categorizadas. Un conocimiento bueno estará definido como > 12 respuestas correctas, un conocimiento regular de 8 a 12 respuestas correctas y un conocimiento malo como < 8 respuestas correctas. Las prácticas también se clasificarán en buenas (31-39 de puntaje), regulares (22-30 de puntaje) y malas (13-21 de puntaje). Las actitudes se clasificarán en positiva (puntajes de 53-65), neutrales (puntajes de 40-52) y negativas (puntajes de 13-39).

La estadística inferencial se desarrollará a través de la prueba Chi cuadrado, la prueba t de student y ANOVA unidireccional para evaluar las diferencias entre grupos, y el coeficiente de correlación de Spearman. Se utilizará un nivel de confianza del 95% y error tipo I del 5%.

4.5. ASPECTOS ÉTICOS

Para la ejecución de la presente investigación, se seguirán los principios de la Declaración de Helsinki, adoptada por la 18° Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964).

Se respetará la confidencialidad, el anonimato de los odontólogos, la participación será voluntaria, se dispondrá de un consentimiento informado (ANEXO N°10) en el cual cada participante lo leerá y firmará su conformidad al aceptar participar del estudio.

5. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

5.1. RECURSOS

5.1.1. Recursos Humanos

- Investigador
- Asesor de Tesis
- Asesor para el manejo estadístico.

5.1.2. Recursos Materiales

- Computadora o laptop
- Cuestionarios físicos y digitales
- Lapiceros

Recursos materiales disponibles:

- Acceso a internet.
- Movilidad vehicular.

5.2. PRESUPUESTO

MATERIALES	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Lapiceros	10	1.00	10.00
Cuestionarios	130	1.00	130.00

Servicios			
Internet	100 horas	1.00	100.00
Trasporte público	130	5.00	650.00
TOTAL			890.00

5.3. FINANCIAMIENTO

La presente investigación será financiada por la propia investigadora.

5.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N°	ACTIVIDAD / TIEMPO	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
01	Ejecución de la tesis y recojo de datos																								
02	Procesamiento y análisis de datos																								
03	Revisión de borrador por el jurado revisor																								
04	Redacción del informe final																								
05	Solicitud para jurado de Sustentación de tesis																								
06	Sustentación de la tesis																								

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Santome-Pariona J, Briceño-Vergel G, Córdova-Limaylla N, Ladera-Castañeda M, Huamani-Echaccaya J, Tolmos-Valdivia R, et al. Factors Associated with the Level of Knowledge about Biosafety against COVID-19 in Peruvian Dental Students: A Cross-Sectional Study under a Multivariable Regression Model. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2023;20(5938):2–14. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10252526/>
2. Romero Tapia P, Marin Aliaga JE, Sedano Balbín G. Bioseguridad en la atención odontológica a partir de la pandemia COVID-19 : un análisis global de las nuevas medidas. *OdontoSanmarquina* [Internet]. 2021;24(1):53–60. Available from: <http://dx.doi.org/10.15381/os.v24i1.19696>
3. Group CovidC. The COVID-19 pandemic and its global effects on dental practice. An International survey. *J Dent* [Internet]. 2021;114:103749. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8285212/>
4. Ather A, Patel B, Ruparel NB, Diogenes A HK. Coronavirus Disease 19 (COVID-19): Implications for Clinical Dental Care. *J Endod* [Internet]. 2020;45(5):584–95. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7270628/>
5. Kumbargere Nagraj S, Eachempati P, Paisi M, Nasser M, Sivaramakrishnan G, Verbeek JH. Interventions to reduce contaminated aerosols produced during dental procedures for preventing infectious diseases. *Cochrane Database Syst Rev* [Internet]. 2020;10(10):CD013686. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8164845/>
6. vega Campojo K. Nivel de conocimiento de los cirujanos dentistas generales y especialistas de Lima Metropolitana sobre los protocolos de bioseguridad para la atención odontológica durante la pandemia por COVID-19 [Internet]. 2022. Available from: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/18065/Vega_cf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
7. Pérez Ancajima IL VCM. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID19 EN ODONTÓLOGOS DEL SECTOR PRIVADO. PIURA METROPOLITANA 2021. 2021.
8. FP EF. Conocimientos y actitudes frente al nuevo coronavirus COVID-19 en cirujanos dentistas de Lima 2020 [Internet]. 2020. Available from: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/18065/Vega_cf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
9. Srivastava KC, Shrivastava D, Sghaireen MG, Alsharari AF, Alduraywish AA, Al-Johani K, et al. Knowledge, attitudes and practices regarding COVID-19 among dental health care professionals: a cross-sectional study in Saudi Arabia. *J Int Med Res* [Internet]. 2020;48(12):1–19. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7739093/>
10. Almarghlani AA, Alshehri MA, Alghmandi AA, Sindi MA, Assaggaf MA A-DN. Infection-Control Knowledge, Attitude, Practice and Risk Perception of Occupational Exposure to COVID-19 Among Dentists: A Cross-Sectional Survey. *Niger J Clin Pract* [Internet]. 2022;25(7):1029–37. Available from: https://journals.lww.com/njcp/fulltext/2022/25070/infection_control_knowledge,_attitude,_practice.8.aspx

11. Săndulescu M, Nicolescu MI, Funieru C, Şahin GÖ, Săndulescu O. Exposure to Biological Fluids in Dental Practice—Narrative Review on Appropriate Risk Assessment to Guide Post-Exposure Management. *Pathogens* [Internet]. 2023;12(7):986. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10383678/>
12. Upendran A, Gupta R GZ. Dental Infection Control [Internet]. In: StatPearls [Internet], Treasure Island (FL). 2022. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29261939/>
13. Saleem H, Waly N, Abdelgawad F. Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) of post exposure prophylaxis for fifth year dental students at a private Egyptian university: a cross-sectional study. *BMC Oral Health* [Internet]. 2023;23(1):1–8. Available from: <https://doi.org/10.1186/s12903-023-02890-7>
14. Directiva Sanitaria N°100/Minsa/2020/DGIESP-Manejo de la Atención Estomatológica en el contexto de la Pandemia por COVID-19. Resolución Ministerial N° 288-2020/MINSA. 2020.
15. Perú CdOd. Protocolos de bioseguridad para cirujanos dentistas durante y post pandemia Covid-19. [Internet]. 2020 [cited 2021 Aug 3]. Available from: <http://www.cop.org.pe/wp-content/uploads/2020/04/PROTOCOLO-DE-BIOSEGURIDAD-PARA-EL-CIRUJANO-DENTISTA.pdf>
16. Rostamzadeh M, Afkhamzadeh A, Afrooz S, Mohamadi K, Rasouli MA. Dentists' knowledge, attitudes and practices regarding Hepatitis B and C and HIV/AIDS in Sanandaj, Iran. *BMC Oral Health* [Internet]. 2018;18(220):1–8. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6299669/>
17. Salazar Ocampo OL. Nivel de conocimientos sobre bioseguridad en odontólogos de la Región Amazonas, 2018 [Internet]. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza De Amazonas; 2018. Available from: Salazar Ocampo OL. Nivel de conocimientos sobre bioseguridad en odontólogos de la Región Amazonas, 2018. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza De Amazonas; 2018.
18. AlAhdal A, Aljehani W, Ali G, Bayoumi A. Knowledge, Attitude and Practice of Infection Control Measures in Private Dental Clinics in Jeddah, Saudi Arabia. *Int J Dent Oral Heal*. 2019;5(1):1–6.
19. Paz Betanco M. Conocimientos, actitudes y prácticas de normas de bioseguridad y riesgo biológico en odontólogos de práctica privada de tres ciudades de Nicaragua. *Odontol Sanmarquina*. 2019;22(1):19–25.
20. Mahasneh AM, Alakhras M, Khabour OF, Al-Sa'di AG, Al-Mousa DS. Practices of infection control among dental care providers: A cross sectional study. *Clin Cosmet Investig Dent* [Internet]. 2020;12:281–9. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7369297/>
21. Sarfaraz S, Shabbir J, Mudasser MA, Khurshid Z, Al-Quraini AAA, Abbasi MS, et al. Knowledge and attitude of dental practitioners related to disinfection during the covid-19 pandemic. *Healthc* [Internet]. 2020;8(232):1–9. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7551794/>
22. Nasser Z, Fares Y, Daoud R, Abou-Abbas L. Assessment of knowledge and practice of dentists towards Coronavirus Disease (COVID-19): a cross-sectional survey from Lebanon. *BMC Oral Health* [Internet]. 2020;20(281):1–9. Available from: <https://doi.org/10.1186/s12903-020-01273-6>

23. Almas K, Khan A, Tabassum A, Nazir M, Afaq A, Majeed A. Knowledge, Attitudes, and Clinical Practices of Dental Professionals during COVID-19 Pandemic in Pakistan. *Eur J Dent* [Internet]. 2020;14(S 01):S63–9. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7840435/>
24. Borja Villanueva CA, Gómez Carrión CE, Alvarado Muñoz ER, Bernuy Torres LA. Conocimiento sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en odontólogos de Lima y Callao. *Rev Científica Odontológica* [Internet]. 2020;8(2):e019. Available from: <https://revistas.cientifica.edu.pe/index.php/odontologica/article/view/696/699>
25. Turska-Szybka A, Prokopczyk M, Winkielman P, Olczak-Kowalczyk D. Knowledge and attitude of Polish dental healthcare professionals during the COVID-19 pandemic. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2021;18(12100):1–17. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8621051/>
26. Koç Y, Akyüz S, Akşit-Bıçak D. Clinical experience, knowledge, attitudes and practice of turkish pediatric dentists during the COVID-19 pandemic. *Med* [Internet]. 2021;57(1140):1–23. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8618506/>
27. García Junchaya AB, Valenzuela Ramos MR, Revilla Villanueva CM. Nivel de conocimiento del manejo de la atención odontológica en el contexto covid-19 en dentistas peruanos. *Rev Investig Científica y Tecnol Llamkasun* [Internet]. 2021;2(4):153–62. Available from: <https://llamkasun.unat.edu.pe/index.php/revista/article/view/70/76>
28. Daniel T. Nivel de conocimiento y actitudes de los odontólogos de las IPRESS públicas nivel I de la DIRIS Lima Centro sobre el control de infección del COVID - 19. Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2023.
29. Rafeek R, Sa B, Smith W. Vaccine Acceptance, Knowledge, Attitude and Practices Regarding the COVID-19 Pandemic: Cross-Sectional Study among Dentists in Trinidad and Tobago. *Dent J* [Internet]. 2023;11(86):1–12. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10046892/>
30. Cañarte Alcívar J, Marín Tello C, Rivera Chavez L, Fernandez Sanchez P, Huerta Vicuña R. El conocimiento en el sistema de salud. *Cienc Digit*. 2019;3(2):508–18.
31. Mamani NS. Conocimiento sobre manejo de los residuos sólidos hospitalarios por el personal de salud del Hospital Santa Rosa Puerto de Maldonado – 2016. Univ Nac Amaz Madre Dios - UNAMAD [Internet]. 2022;103. Available from: <http://repositorio.unamad.edu.pe/handle/20.500.14070/205%0Ahttp://repositorio.unamad.edu.pe/handle/UNAMAD/205%0Ahttp://repositorio.unamad.edu.pe/bitstream/handle/UNAMAD/205/004-1-9-002.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
32. García Mendoza Y. Concepto y definición de conocimiento. Univ Autónoma del Estado Hidalgo [Internet]. Available from: <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n8/m12.html>
33. Garzón Gómez M. Importancia de la actitud del docente en el proceso de aprendizaje. [Internet]. Pontificia Universidad Católica del Perú. Universidad Pedagógica Nacional; 2014. Available from: <http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/571/TO-17150.pdf?sequence=1&isAll>
34. Montero Saldarriag S. Conocimiento, actitudes y Prácticas Sobre Medidas De

- Bioseguridad Frente a Riesgos Biologicos En Centro Quirurgico [Internet]. Universidad San Pedro. Facultad de Enfermería; 2018. Available from: http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/7092/Tesis_59190.pdf?sequence=1&isAllowed=y
35. Briñol P, Falces C, Becerra A. Actitudes. En Morales, FJ., Moya MC., Gaviria, E., Cuadrado, I [Internet]. 3era Edici. Psicología Social. 2004. 457–490 p. Available from: <https://pablobrinol.com/wp-content/uploads/papers/Actitudes.pdf>
 36. Ubillos S, Mayordomo S, Páez D. Actitudes. Rev Psicol [Internet]. 1994;(1958):37. Available from: <https://ehu.eus/documents/1463215/1504276/Capitulo+X.pdf>
 37. Valdivia Mendoza N. Conocimiento y prácticas sobre medidas de bioseguridad del profesional de enfermería en el área de centro quirúrgico [Internet]. Universidad Norbert Wiener. Facultad de Ciencias de la Salud.; 2022. Available from: https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/7365/T061_47160706_S.pdf?sequence=1
 38. Álvarez Barahona, Fernando Martín; Juna Juca CF. Conocimientos y prácticas sobre bioseguridad en odontólogos de los centros de salud de Latacunga. Enfermería Investig Investig Vinculación, Docencia y Gestión. 2017;2(2):59–63.
 39. Ministerio de Salud. Documento técnico: Plan de bioseguridad del Hospital Víctor Larco Herrera. 2022.
 40. Minsa. Manual De Bioseguridad; Unidad De Soporte Al Diagnóstico Y Tratamiento Sub Unidad De Soporte Al Diagnóstico Servicio De Patología Clínica. 2020;1–38.
 41. BecerraTerán G, Pizán Acuña M. Nivel de conocimiento de medidas de bioseguridad frente al Covid-19 de estudiantes de estomatología, Cajamarca.2020. 2020.
 42. Ruiz-Hernández AR F-GJ. Principios de bioseguridad en los servicios estomatológicos. Medicent Electrón. 2013;17(2):49–55.
 43. Técnica N. Norma técnica bioseguridad en odontología 2005. 2005;1–63.
 44. Recomendaciones clínicas para realizar procedimientos en odontoestomatología en el contexto de pandemia por covid -19. LInstituto evaluación Tecnol en salud e Investig Essalud; 2020;
 45. Colegio Odontológico de Lima. Líneas guía para la atención odonológica en el periodo de la crisis por Covid-19. 2020; Available from: https://issuu.com/colegioodontologicodelima/docs/lineas_guia_odontologia_covid_19
 46. Salud OP de la. La higiene de manos salva vidas [Internet]. 2021. Available from: <https://www.paho.org/es/noticias/17-11-2021-higiene-manos-salva-vidas>
 47. Health OW. Manual técnico de referencia para la higiene de las manos [Internet]. SAVE LIVES Clean Your Hands. 2010. p. 1–32. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/102537/1/WHO_IER_PSP_2009.02_spa.pdf
 48. Muñoz Huamán DJ, Fernández Bravo FH, Chiroque Pérez TE, Román Campos Samuel AN, Villalobos Veliz L del C, Valenzuela Ramos MR. Protocolos de bioseguridad para la atención odontológica durante la pandemia COVID-19 en

- países de América Latina. *Llamkasun*. 2021;2(3):80–104.
49. Ministerio de Salud. Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria. MINSA Lima. 2002;
 50. Barboza Astonitas AD. Nivel de conocimiento y cumplimiento de las normas de bioseguridad de los estudiantes en la Clínica de Cirugía Bucomaxilofacial de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del año 2018. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Odontología; 2018.
 51. Figueroa Córdova AL, Siguencia Matute EJ, Batten Cuadrado MI, Lara Hernández MF. Documento Técnico: Recomendaciones para el uso apropiado de mascarillas y respiradores por el personal de salud en el contexto del COVID-19 [Internet]. Vol. 3, *Journal of America health*. 2020. p. 10–20. Available from: <http://mafirma-legislacion2.s3.amazonaws.com/2020-05-03/R.M. 248-2020-MINSA.pdf?fbclid=IwAR05qz8JYM5-VoXsivSdVbqXnVFr7EZ88uWHfYtQZX2il8y8IlmP34RbEXI>
 52. Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH C. Cómo prevenir las lesiones por pinchazos de aguja y objetos cortopunzantes [Internet]. 2012. Available from: https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2012-123_sp/default.html
 53. Rodríguez RP, Lozano F, González De Castro P, Blanco JR, Dueñas C. PANEL DE EXPERTOS DE GeSIDA. 2015;1–69. Available from: <http://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2017/02/gesida-guiasclinicas-2015-profilaxispostexposicion-VIH-VHC-VHB.pdf>
 54. Colegio profesional de higienistas dentales de Madrid. Natalia C. Protocolo de actuación en accidentes con instrumentos punzantes o agujas [Internet]. 2021. Available from: <https://colegiohigienistasmadrid.org/blog/?p=903>
 55. Zhang Z, Gao X, Ruan X, Zheng B. Effectiveness of double-gloving method on prevention of surgical glove perforations and blood contamination: A systematic review and meta-analysis. *J Adv Nurs* [Internet]. 2021;77(9):3630–43. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14824>
 56. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. [Internet]. 2020. [cited 2021 Aug 2]. Available from: <https://dle.rae.es/conocimiento>

7. ANEXOS

Anexo 1: Instrumento para medir el Nivel de Conocimientos sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS ODONTÓLOGOS SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Estimado participante:

El presente cuestionario tiene como objetivo determinar el nivel de conocimientos en cuanto a medidas de bioseguridad. Es de carácter anónimo y confidencial, los resultados se emplearán solo con fines del estudio. Esperando contar con su sinceridad en las respuestas, agradezco por anticipado su valiosa participación.

INSTRUCCIONES: A continuación, se le presentará una serie de preguntas. Todas las preguntas presentan una sola respuesta correcta, se sugiere leer cuidadosamente y responder marcando con una (X) la alternativa que usted considere correcta.

DATOS GENERALES:

- ✓ Edad:
- ✓ Sexo: Masculino () Femenino ()
- ✓ Nombre del Establecimiento de Salud:
- ✓ Años de experiencia profesional:

A. GENERALIDADES DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

1. **¿Cuáles de las siguientes enfermedades infecciosas se transmiten principalmente por contacto con sangre infectada?**
 - a. VIH/SIDA, VHB, tuberculosis, VHC
 - b. VIH/ SIDA, VHB, VHC
 - c. VIH/SIDA, Covid-19, VHB, VHC
 - d. VIH/SIDA, Tuberculosis, dengue
2. **Son enfermedades infecciosas que el odontólogo puede contraer por medio de gotitas y partículas presentes en ambiente:**
 - a. Covid-19, dengue, tuberculosis
 - b. Covid-19, tuberculosis, influenza
 - c. VIH/SIDA, VHC
 - d. Tuberculosis, VHB
3. **Son enfermedades infecciosas que se transmiten en el consultorio odontológico por contacto con la saliva y mucosas de pacientes infectados:**
 - a. Covid-19, tuberculosis, VHC
 - b. COVID-19, VHB, herpes simple
 - c. VIH/SIDA, VHC, VHB, herpes simple
 - d. VHC, herpes simple, influenza

B. BARRERAS DE PROTECCIÓN

4. Según la OMS, ¿Cuál es el periodo de tiempo que se debe emplear en el lavado clínico de manos con agua y jabón para prevenir infecciones?
 - a. 5-10 segundos
 - b. 20 a 40 segundos
 - c. 40 a 60 segundos
 - d. Más de 1 minuto
5. Según el MINSA ¿Cuál es la secuencia recomendada para la colocación del equipo de protección personal?
 - a. Mandilón, gorro, mascarilla o respirador, protector facial, guantes
 - b. Gorro, mandilón, mascarilla o respirador, protector facial, guantes
 - c. Mandilón, mascarilla o respirador, gorro, protector facial, guantes
 - d. mascarilla o respirador, mandilón, gorro, protector facial, guantes
6. Según el MINSA ¿Cuál es la secuencia correcta para el retiro de los elementos del equipo de protección personal?
 - a. Protector facial, guantes, mandilón, mascarilla y gorro.
 - b. Guantes, protector facial, mascarilla, gorro y mandilón.
 - c. Guantes, protector facial, mandilón, mascarilla y gorro.
 - d. Guantes, protector facial, mandilón, gorro y mascarilla.
- 7.Cuál de los enunciados es incorrecto en referente a las mascarillas.
 - a. Los respiradores deben cubrir completamente la nariz, mentón y tener un buen ajuste
 - b. Para su retiro se puede sujetar por la parte delantera.
 - c. Los respiradores deben tener una eficiencia de filtrado $\geq 95\%$
 - d. Los respiradores N95 pueden tener más de un uso, para ello serán envueltos y guardados en una bolsa no transpirable de tela o papel.
8. Con respecto al protector facial, ¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto?
 - a. Protege los ojos y rostro de salpicaduras de fluidos y factores externos como golpes.
 - b. La limpieza se debe realizar con agua y jabón para no deteriorarla y evitar que se empañe.
 - c. Para su retiro, debe sostenerse por la parte de la banda de la cabeza.
 - d. Su uso puede sustituir el uso del respirador.

C. MANEJO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

9. ¿Cuáles son las sustancias que se utilizan en una desinfección de alto nivel?
 - a. Cetrimida, cloruro de benzalconio, ortoftaldehído, glutaraldehído y fenoles.
 - b. Ortoftaldehído, glutaraldehído, ácido peracético, peróxido de hidrógeno y formaldehído.
 - c. Glutaraldehído, ortoftaldehído, peróxido de hidrógeno, ácido peracético y alcohol isopropílico.
 - d. Clorhexidina, alcohol etílico, alcohol isopropílico y cloruro de benzalconio.

10. **Para la desinfección y descontaminación de superficies en el consultorio odontológico, se utilizan las siguientes sustancias**
- a. Hipoclorito de sodio al 0.1 %
 - b. Hipoclorito de sodio desde 0.1%, peróxido de hidrógeno 0.5% y etanol del 62-71%
 - c. Hipoclorito de sodio desde 0.1%, peróxido de hidrógeno 2% y etanol del 90%
 - d. Solo hipoclorito de sodio al 0.1% y peróxido de hidrógeno al 0.5 %
11. **¿Cuál es la secuencia que se debe seguir durante el proceso de esterilización del instrumental odontológico?**
- a. Desinfección, preparación y empaque, esterilización en autoclave o estufa y almacenamiento del material.
 - b. Lavado, desinfección, preparación y empaque, esterilización en autoclave o estufa y almacenamiento.
 - c. Desinfección, lavado, preparación y empaque, esterilización en autoclave o estufa y almacenamiento.
 - d. Limpieza, desinfección, preparación y empaque, esterilización en autoclave o estufa y almacenamiento.
12. **Con respecto a la limpieza, desinfección y esterilización de los dispositivos odontológicos ¿Qué enunciado es incorrecto?**
- a. Para garantizar una adecuada limpieza se debe utilizar detergente enzimático.
 - b. La pieza de mano, motor de baja velocidad y contra ángulo deben desinfectarse con agentes químicos de alto nivel de desinfección.
 - c. Los instrumentos semicríticos deberán esterilizarse o desinfectarse por alto e intermedio nivel de desinfección, según el tipo de material.
 - d. Los instrumentos estériles almacenados necesitan de inspección antes de su uso para verificar que no se encuentren contaminados.
13. **¿En qué color de bolsa deben desecharse los elementos del equipo de protección personal al finalizar la atención en odontología?**
- a. Negra o roja
 - b. Roja
 - c. Negra
 - d. Amarilla o negra

D. ACCIDENTES DE EXPOSICIÓN A SANGRE O FLUIDOS CORPORALES

14. **Son medidas de urgencia a realizan ante accidentes de exposición a sangre o fluidos corporales, excepto:**
- a) En casos de pinchazos y heridas: retirar guantes, lavar con abundante agua y jabón.
 - b) En casos de contacto con mucosas: hacer lavado profuso con agua o suero fisiológico por 10 minutos.
 - c) En casos de contacto con mucosas se pueden utilizar desinfectantes.
 - d) En casos de contacto con piel intacta: realizar arrastre mecánico con abundante agua durante 10 minutos
15. **¿Cuál es el momento preferible para recibir una profilaxis post exposición sanguínea, que involucre virus de VHB, VHC y VIH?**

- a) Dentro de 1 hora
- b) Dentro de 6 horas
- c) Dentro de 12 horas
- d) Dentro de 72 horas

16. ¿Cuál es el tiempo máximo de demora para comenzar con la profilaxis post exposición sanguínea, que involucre virus de VHB, VHC y VIH?

- a) Hasta 12 hora
- b) Hasta 24 horas
- c) Hasta 48 horas
- d) Hasta 72 horas

Anexo 2: Validación del instrumento para medir el Nivel de Conocimientos sobre las medidas de bioseguridad en los odontólogos de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

JUICIO DE EXPERTOS -VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTÓLOGOS DE LAS IPRESS PÚBLICAS DEL NIVEL I DE LA DIRIS LIMA CENTRO

INDICACIONES: Luego de analizar la operacionalización de variables y los ítems del instrumento determine si éste reúne los indicadores. Evalúe de acuerdo a la valoración siguiente:

Muy bueno (81%-100%),	Bueno (61%-80%),	Regular (41%-60%),	Malo (21%-40%),	Muy malo (1%-20%).
--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Marque con un aspa (x) la apreciación correspondiente en el casillero.

N°	INDICADORES	DEFINICIÓN	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Preguntas con correspondencia y relación adecuada de todas las partes que forman un todo.	X				
2	Relevancia	Preguntas esenciales e importantes que deben ser incluidas.	X				
3	Validez	Preguntas correctas y eficaces que se ajusta a la ley valor.	X				
4	Organización	Preguntas estructuradas con orden y de acuerdo con indicadores propuestos.	X				
5	Claridad	Preguntas redactadas con expresiones entendibles por el encuestado.	X				
6	Precisión	Preguntas con exactitud y determinación.	X				
7	Coherencia	Las preguntas guardan relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	X				
8	Suficiencia	La cantidad de preguntas asignadas a cada dimensión es la adecuada.	X				
Observaciones							

Nombres y Apellidos del experto	ELMO PALACIOS ALVA
Grado Académico	DOCTOR
Institución donde labora	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Fecha de validación	09/11/2023
DNI	06628162
Firma	

JUICIO DE EXPERTOS - VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

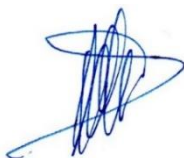
CONOCIMIENTOS SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTÓLOGOS DE LAS IPRESS PÚBLICAS DEL NIVEL I DE LA DIRIS LIMA CENTRO

INDICACIONES: Luego de analizar la operacionalización de variables y los ítems del instrumento determine si éste reúne los indicadores. Evalúe de acuerdo a la valoración siguiente:

Muy bueno (81%-100%),	Bueno (61%-80%),	Regular (41%-60%),	Malo (21%-40%),	Muy malo (1%-20%).
--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Marque con un aspa (x) la apreciación correspondiente en el casillero.

N°	INDICADORES	DEFINICIÓN	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Preguntas con correspondencia y relación adecuada de todas las partes que forman un todo.	X				
2	Relevancia	Preguntas esenciales e importantes que deben ser incluidas.	X				
3	Validez	Preguntas correctas y eficaces que se ajusta a la ley valor.	X				
4	Organización	Preguntas estructuradas con orden y de acuerdo con indicadores propuestos.	X				
5	Claridad	Preguntas redactadas con expresiones entendibles por el encuestado.	X				
6	Precisión	Preguntas con exactitud y determinación.	X				
7	Coherencia	Las preguntas guardan relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	X				
8	Suficiencia	La cantidad de preguntas asignadas a cada dimensión es la adecuada.	X				
Observaciones							

Nombres y Apellidos del experto	ANTONIA CASTRO RODRÍGUEZ
Grado Académico	DOCTOR
Institución donde labora	UNMSM
Fecha de validación	17 NOVIEMBRE 2023
DNI	07215663
Firma	

JUICIO DE EXPERTOS - VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

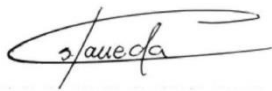
CONOCIMIENTOS SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTÓLOGOS DE LAS IPRESS PÚBLICAS DEL NIVEL I DE LA DIRIS LIMA CENTRO

INDICACIONES: Luego de analizar la operacionalización de variables y los ítems del instrumento determine si éste reúne los indicadores. Evalúe de acuerdo a la valoración siguiente:

Muy bueno (81%-100%),	Bueno (61%-80%),	Regular (41%-60%),	Malo (21%-40%),	Muy malo (1%-20%).
--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Marque con un aspa (x) la apreciación correspondiente en el casillero.

N°	INDICADORES	DEFINICIÓN	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Preguntas con correspondencia y relación adecuada de todas las partes que forman un todo.	X				
2	Relevancia	Preguntas esenciales e importantes que deben ser incluidas.	X				
3	Validez	Preguntas correctas y eficaces que se ajusta a la ley valor.	X				
4	Organización	Preguntas estructuradas con orden y de acuerdo con indicadores propuestos.	X				
5	Claridad	Preguntas redactadas con expresiones entendibles por el encuestado.	X				
6	Precisión	Preguntas con exactitud y determinación.	X				
7	Coherencia	Las preguntas guardan relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	X				
8	Suficiencia	La cantidad de preguntas asignadas a cada dimensión es la adecuada.	X				
Observaciones							

Nombres y Apellidos del experto	SARA CASTAÑEDA SARMIENTO
Grado Académico	DOCTOR
Institución donde labora	UNMSM
Fecha de validación	06-12-23
DNI	21528573
Firma	

JUICIO DE EXPERTOS - VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTÓLOGOS DE LAS IPRESS PÚBLICAS DEL NIVEL I DE LA DIRIS LIMA CENTRO

INDICACIONES: Luego de analizar la operacionalización de variables y los ítems del instrumento determine si éste reúne los indicadores. Evalúe de acuerdo a la valoración siguiente:

Muy bueno (81%-100%),	Bueno (61%-80%),	Regular (41%-60%),	Malo (21%-40%),	Muy malo (1%-20%).
--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Marque con un aspa (x) la apreciación correspondiente en el casillero.

N°	INDICADORES	DEFINICIÓN	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Preguntas con correspondencia y relación adecuada de todas las partes que forman un todo.	X				
2	Relevancia	Preguntas esenciales e importantes que deben ser incluidas.	X				
3	Validez	Preguntas correctas y eficaces que se ajusta a la ley valor.	X				
4	Organización	Preguntas estructuradas con orden y de acuerdo con indicadores propuestos.	X				
5	Claridad	Preguntas redactadas con expresiones entendibles por el encuestado.	X				
6	Precisión	Preguntas con exactitud y determinación.	X				
7	Coherencia	Las preguntas guardan relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	X				
8	Suficiencia	La cantidad de preguntas asignadas a cada dimensión es la adecuada.	X				
Observaciones							

Nombres y Apellidos del experto	ALEJANDRO ALBERTO CORNEJO GARCÍA
Grado Académico	CD.ESPECIALISTA
Institución donde labora	UNMSM
Fecha de validación	15-DICIEMBRE 2023
DNI	10474146
Firma	

JUICIO DE EXPERTOS - VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTÓLOGOS DE LAS IPRESS PÚBLICAS DEL NIVEL I DE LA DIRIS LIMA CENTRO

INDICACIONES: Luego de analizar la operacionalización de variables y los ítems del instrumento determine si éste reúne los indicadores. Evalúe de acuerdo a la valoración siguiente:

Muy bueno (81%-100%),	Bueno (61%-80%),	Regular (41%-60%),	Malo (21%-40%),	Muy malo (1%-20%).
--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Marque con un aspa (x) la apreciación correspondiente en el casillero.

N°	INDICADORES	DEFINICIÓN	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Preguntas con correspondencia y relación adecuada de todas las partes que forman un todo.		X			
2	Relevancia	Preguntas esenciales e importantes que deben ser incluidas.		X			
3	Validez	Preguntas correctas y eficaces que se ajusta a la ley valor.		X			
4	Organización	Preguntas estructuradas con orden y de acuerdo con indicadores propuestos.		X			
5	Claridad	Preguntas redactadas con expresiones entendibles por el encuestado.		X			
6	Precisión	Preguntas con exactitud y determinación.		X			
7	Coherencia	Las preguntas guardan relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.		X			
8	Suficiencia	La cantidad de preguntas asignadas a cada dimensión es la adecuada.		X			
Observaciones							

Nombres y Apellidos del experto	JHAMES IVAN ORE DE LA CRUZ
Grado Académico	DOCTOR
Institución donde labora	UNMSM – HNAL
Fecha de validación	18-01-24
DNI	20576287
Firma	

Anexo 3. Prueba V de Aiken del instrumento para evaluar el nivel de conocimientos sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

V DE AIKEN – CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS					
DIMENSIÓN	PREGUNTAS/ ITEMS	CLARIDAD	COHERENCIA	RELEVANCIA	SUFICIENCIA
Generalidades de las enfermedades infecciosas transmisibles en la consulta odontológica	1	0.87	1	1	1
	2	1	1	1	
	3	1	1	1	
Barreras de Protección	4	0.94	1	1	0.94
	5	1	1	1	
	6	1	1	1	
	7	1	1	1	
	8	0.94	1	1	
Manejo y eliminación de residuos	9	1	1	0.94	0.94
	10	1	1	0.94	
	11	1	1	1	
	12	0.94	1	1	
	13	1	1	1	
Medidas ante accidentes de exposición a sangre y fluidos corporales	14	1	1	1	1
	15	1	1	1	
	16	1	1	1	
V DE AIKEN		0.981	1	0.993	0.97

Anexo 4: Instrumento para medir el Nivel de Actitudes sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LAS ACTITUDES DE LOS ODONTÓLOGOS SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

El presente cuestionario tiene como objetivo identificar la actitud hacia las medidas de bioseguridad. Los resultados se utilizarán solo con fines del estudio y es de carácter anónimo y confidencial. Esperando contar con su veracidad en las respuestas agradezco su valiosa participación.

INSTRUCCIONES: Marque con una X o un círculo la casilla que Ud. Considere apropiada según el enunciado.

TD: Totalmente en desacuerdo D: Desacuerdo I: Indiferente A: De acuerdo TA: Totalmente de acuerdo						
N°	ENUNCIADOS	TD	D	I	A	TA
1	El miedo y la preocupación por infectarse con VHB, VHC, VIH/SIDA, Covid-19 no deberían ser una de las razones para evitar tratar a los pacientes infectados.	1	2	3	4	5
2	El uso de pieza de mano y otros equipos generadores de aerosoles en pacientes con Covid-19, tuberculosis e influenza generan un peligro para la salud del profesional y la de los pacientes.	1	2	3	4	5
3	Independientemente de las precauciones clínicas, existe riesgo de transmisión de VIH/Sida, Hepatitis, Covid-19, entre otras, del paciente al dentista y viceversa.	1	2	3	4	5
4	Todos los pacientes deben considerarse como potencialmente infecciosos.	1	2	3	4	5
5	La vacunación completa es la mejor forma de prevenir la infección por VHB y nos protege contra el Covid-19, influenza y otras enfermedades infecciosas.	1	2	3	4	5
6	Es imprescindible usar equipo de protección personal completo, a pesar de que su uso genere incomodidad.	1	2	3	4	5
7	Las gafas o protector facial se deben usar siempre durante la atención dental.	1	2	3	4	5
8	El método de usar doble guante disminuye el riesgo de transmisión de enfermedades como el VIH/Sida, VHC y VHB.	1	2	3	4	5
9	La esterilización por vapor debería ser la primera opción para eliminar patógenos en los instrumentos rotatorios como piezas de mano, micromotor, etc.	1	2	3	4	5
10	Luego de colocar la anestesia no es necesario volver a tapar la aguja utilizada antes de eliminarla en un contenedor rígido.	1	2	3	4	5
11	La inadecuada eliminación de los residuos contaminados genera un peligro para la salud del personal.	1	2	3	4	5
12	Considera que la técnica de cubrir o tapar la aguja con una mano favorece la prevención de infecciones de transmisión sanguínea por pinchazos con agujas.	1	2	3	4	5
13	Es importante seguir un protocolo ante casos de exposición a sangre o fluidos corporales.	1	2	3	4	5
14	La profilaxis post exposición ayuda a prevenir una mayor infección.	1	2	3	4	5
15	Una forma rápida para conocer si el paciente fuente presenta la infección por VHB, VHC, y/o VIH/Sida es por medio de las pruebas rápidas.	1	2	3	4	5

Anexo 5. Validación del instrumento para medir el Nivel de Actitudes sobre las medidas de bioseguridad en los odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

JUICIO DE EXPERTOS -VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

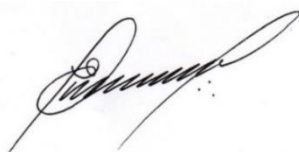
ACTITUDES SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTÓLOGOS DE LAS IPRESS PÚBLICAS DEL NIVEL I DE LA DIRIS LIMA CENTRO

INDICACIONES: Luego de analizar la operacionalización de variables y los ítems del instrumento determine si éste reúne los indicadores. Evalúe de acuerdo a la valoración siguiente:

Muy bueno (81%-100%),	Bueno (61%-80%),	Regular (41%-60%),	Malo (21%-40%),	Muy malo (1%-20%).
--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Marque con un aspa (x) la apreciación correspondiente en el casillero.

N°	INDICADORES	DEFINICIÓN	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Preguntas con correspondencia y relación adecuada de todas las partes que forman un todo.	X				
2	Relevancia	Preguntas esenciales e importantes que deben ser incluidas.	X				
3	Validez	Preguntas correctas y eficaces que se ajusta a la ley valor.	X				
4	Organización	Preguntas estructuradas con orden y de acuerdo con indicadores propuestos.	X				
5	Claridad	Preguntas redactadas con expresiones entendibles por el encuestado.	X				
6	Precisión	Preguntas con exactitud y determinación.	X				
7	Coherencia	Las preguntas guardan relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	X				
8	Suficiencia	La cantidad de preguntas asignadas a cada dimensión es la adecuada.	X				
Observaciones							

Nombres y Apellidos del experto	ELMO PALACIOS ALVA
Grado Académico	DOCTOR
Institución donde labora	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Fecha de validación	09/11/2023
DNI	06628162
Firma	

JUICIO DE EXPERTOS -VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

ACTITUDES SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTÓLOGOS DE LAS IPRESS PÚBLICAS DEL NIVEL I DE LA DIRIS LIMA CENTRO

INDICACIONES: Luego de analizar la operacionalización de variables y los ítems del instrumento determine si éste reúne los indicadores. Evalúe de acuerdo a la valoración siguiente:

Muy bueno (81%-100%),	Bueno (61%-80%),	Regular (41%-60%),	Malo (21%-40%),	Muy malo (1%-20%).
--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Marque con un aspa (x) la apreciación correspondiente en el casillero.

N°	INDICADORES	DEFINICIÓN	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Preguntas con correspondencia y relación adecuada de todas las partes que forman un todo.	X				
2	Relevancia	Preguntas esenciales e importantes que deben ser incluidas.	X				
3	Validez	Preguntas correctas y eficaces que se ajusta a la ley valor.	X				
4	Organización	Preguntas estructuradas con orden y de acuerdo con indicadores propuestos.	X				
5	Claridad	Preguntas redactadas con expresiones entendibles por el encuestado.	X				
6	Precisión	Preguntas con exactitud y determinación.	X				
7	Coherencia	Las preguntas guardan relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	X				
8	Suficiencia	La cantidad de preguntas asignadas a cada dimensión es la adecuada.	X				
Observaciones							

Nombres y Apellidos del experto	ANTONIA CASTRO RODRÍGUEZ
Grado Académico	DOCTOR
Institución donde labora	UNMSM
Fecha de validación	17 NOVIEMBRE 2023
DNI	07215663
Firma	

JUICIO DE EXPERTOS -VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

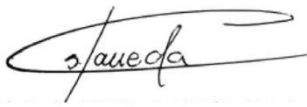
ACTITUDES SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTÓLOGOS DE LAS IPRESS PÚBLICAS DEL NIVEL I DE LA DIRIS LIMA CENTRO

INDICACIONES: Luego de analizar la operacionalización de variables y los ítems del instrumento determine si éste reúne los indicadores. Evalúe de acuerdo a la valoración siguiente:

Muy bueno (81%-100%),	Bueno (61%-80%),	Regular (41%-60%),	Malo (21%-40%),	Muy malo (1%-20%).
--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Marque con un aspa (x) la apreciación correspondiente en el casillero.

N°	INDICADORES	DEFINICIÓN	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Preguntas con correspondencia y relación adecuada de todas las partes que forman un todo.	X				
2	Relevancia	Preguntas esenciales e importantes que deben ser incluidas.	X				
3	Validez	Preguntas correctas y eficaces que se ajusta a la ley valor.	X				
4	Organización	Preguntas estructuradas con orden y de acuerdo con indicadores propuestos.	X				
5	Claridad	Preguntas redactadas con expresiones entendibles por el encuestado.	X				
6	Precisión	Preguntas con exactitud y determinación.	X				
7	Coherencia	Las preguntas guardan relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	X				
8	Suficiencia	La cantidad de preguntas asignadas a cada dimensión es la adecuada.	X				
Observaciones							

Nombres y Apellidos del experto	SARA CASTAÑEDA SARMIENTO
Grado Académico	DOCTOR
Institución donde labora	UNMSM
Fecha de validación	06-12-23
DNI	21528573
Firma	

JUICIO DE EXPERTOS -VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

ACTITUDES SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTÓLOGOS DE LAS IPRESS PÚBLICAS DEL NIVEL I DE LA DIRIS LIMA CENTRO

INDICACIONES: Luego de analizar la operacionalización de variables y los ítems del instrumento determine si éste reúne los indicadores. Evalúe de acuerdo a la valoración siguiente:

Muy bueno (81%-100%),	Bueno (61%-80%),	Regular (41%-60%),	Malo (21%-40%),	Muy malo (1%-20%).
--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Marque con un aspa (x) la apreciación correspondiente en el casillero.

N°	INDICADORES	DEFINICIÓN	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Preguntas con correspondencia y relación adecuada de todas las partes que forman un todo.	X				
2	Relevancia	Preguntas esenciales e importantes que deben ser incluidas.	X				
3	Validez	Preguntas correctas y eficaces que se ajusta a la ley valor.	X				
4	Organización	Preguntas estructuradas con orden y de acuerdo con indicadores propuestos.	X				
5	Claridad	Preguntas redactadas con expresiones entendibles por el encuestado.	X				
6	Precisión	Preguntas con exactitud y determinación.	X				
7	Coherencia	Las preguntas guardan relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	X				
8	Suficiencia	La cantidad de preguntas asignadas a cada dimensión es la adecuada.	X				
Observaciones							

Nombres y Apellidos del experto	ALEJANDRO ALBERTO CORNEJO GARCÍA
Grado Académico	CD.ESPECIALISTA
Institución donde labora	UNMSM
Fecha de validación	15-DICIEMBRE 2023
DNI	10474146
Firma	

JUICIO DE EXPERTOS -VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

ACTITUDES SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTÓLOGOS DE LAS IPRESS PÚBLICAS DEL NIVEL I DE LA DIRIS LIMA CENTRO

INDICACIONES: Luego de analizar la operacionalización de variables y los ítems del instrumento determine si éste reúne los indicadores. Evalúe de acuerdo a la valoración siguiente:

Muy bueno (81%-100%),	Bueno (61%-80%),	Regular (41%-60%),	Malo (21%-40%),	Muy malo (1%-20%).
--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Marque con un aspa (x) la apreciación correspondiente en el casillero.

N°	INDICADORES	DEFINICIÓN	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Preguntas con correspondencia y relación adecuada de todas las partes que forman un todo.		X			
2	Relevancia	Preguntas esenciales e importantes que deben ser incluidas.		X			
3	Validez	Preguntas correctas y eficaces que se ajusta a la ley valor.		X			
4	Organización	Preguntas estructuradas con orden y de acuerdo con indicadores propuestos.		X			
5	Claridad	Preguntas redactadas con expresiones entendibles por el encuestado.		X			
6	Precisión	Preguntas con exactitud y determinación.		X			
7	Coherencia	Las preguntas guardan relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.		X			
8	Suficiencia	La cantidad de preguntas asignadas a cada dimensión es la adecuada.		X			
Observaciones							

Nombres y Apellidos del experto	JHAMES IVAN ORE DE LA CRUZ
Grado Académico	DOCTOR
Institución donde labora	UNMSM – HNAL
Fecha de validación	18-01-24
DNI	20576287
Firma	

Anexo 6. Prueba V de Aiken del instrumento para evaluar el nivel de Actitudes sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

V DE AIKEN – CUESTIONARIO DE ACTITUDES					
DIMENSIÓN	PREGUNTAS/ ITEMS	CLARIDAD	COHERENCIA	RELEVANCIA	SUFICIENCIA
Transmisión de infecciones	1	0.87	1	1	1
	2	1	1	1	
	3	1	1	1	
	4	1	1	1	
Uso de barreras de protección	5	1	0.8	0.8	
	6	1	1	1	
	7	1	1	1	
	8	0.94	1	1	
Manejo y eliminación de residuos	9	1	1	1	1
	10	0.87	1	1	
	11	1	1	1	
Medidas ante accidentes de exposición a sangre y fluidos corporales	12	1	0.8	0.8	
	13	1	1	1	
	14	1	1	1	
	15	1	1	1	
V DE AIKEN		0.979	0.973	0.973	1

Anexo 7. Instrumento para medir el Nivel de Prácticas sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LAS PRÁCTICAS DE LOS ODONTÓLOGOS SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

El presente cuestionario tiene como objetivo identificar las prácticas con respecto a las medidas de bioseguridad. Los resultados se utilizarán solo con fines del estudio y es de carácter anónimo y confidencial. Esperando contar con su sinceridad en las respuestas agradezco por anticipado su valiosa participación.

INSTRUCCIONES: Marque con una X o un círculo la casilla que Ud. Considere apropiada según el enunciado.

N°		SIEMPRE	A VECES	NUNCA
	USO DE BARRERAS			
1	¿Ha recibido vacunación completa contra la Hepatitis B, Covid-19 e influenza?			
2	¿Utiliza EPP completo: mascarilla, guantes, protector facial o lentes protectores, gorro, mandilón?			
3	¿Utiliza respiradores N95 o equivalentes para procedimientos generadores de aerosoles?			
4	¿Se cambia los guantes después de atender a cada paciente?			
5	¿Se realiza la higiene de manos antes de colocarse los guantes e inmediatamente después de retirárselos?			
	MANEJO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS			
6	¿Desinfecta el sillón dental, la luz y superficies del consultorio después de atender a cada paciente?			
7	¿Desecha los materiales punzocortantes en un contenedor rígido?			
8	¿Elimina los residuos contaminados en diferentes bolsas según las clasificaciones?			
9	¿Esteriliza los instrumentos y las piezas de mano después de cada uso con el paciente?			
10	¿Ha modificado la ventilación /flujo de aire en el consultorio?			
11	Se cambia y lava su uniforme médico todos los días después de atender a los pacientes.			
	MEDIDAS ANTE ACCIDENTES DE EXPOSICIÓN A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES			
12	¿Utiliza una pinza porta aguja o similar para reinsertar la cubierta de la aguja y para retirar la aguja de la jeringa cárpule?			
13	Sigue un protocolo de bioseguridad en casos de presentar accidentes de exposición a sangre o fluidos corporales			
14	Ha recibido profilaxis post exposición después de una exposición sanguínea que involucre virus de VHB, VHC y VIH			

Anexo 8. Validación del instrumento para medir el Nivel de Actitudes sobre las medidas de bioseguridad en los odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

JUICIO DE EXPERTOS -VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

PRÁCTICAS SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTÓLOGOS DE LAS IPRESS PÚBLICAS DEL NIVEL I DE LA DIRIS LIMA CENTRO

INDICACIONES: Luego de analizar la operacionalización de variables y los ítems del instrumento determine si éste reúne los indicadores. Evalúe de acuerdo a la valoración siguiente:

Muy bueno (81%-100%),	Bueno (61%-80%),	Regular (41%-60%),	Malo (21%-40%),	Muy malo (1%-20%).
--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Marque con un aspa (x) la apreciación correspondiente en el casillero.

N°	INDICADORES	DEFINICIÓN	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Preguntas con correspondencia y relación adecuada de todas las partes que forman un todo.	X				
2	Relevancia	Preguntas esenciales e importantes que deben ser incluidas.	X				
3	Validez	Preguntas correctas y eficaces que se ajusta a la ley valor.	X				
4	Organización	Preguntas estructuradas con orden y de acuerdo con indicadores propuestos.	X				
5	Claridad	Preguntas redactadas con expresiones entendibles por el encuestado.	X				
6	Precisión	Preguntas con exactitud y determinación.	X				
7	Coherencia	Las preguntas guardan relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	X				
8	Suficiencia	La cantidad de preguntas asignadas a cada dimensión es la adecuada.	X				
Observaciones							

Nombres y Apellidos del experto	ELMO PALACIOS ALVA
Grado Académico	DOCTOR
Institución donde labora	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Fecha de validación	09/11/2023
DNI	06628162
Firma	

JUICIO DE EXPERTOS -VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

PRÁCTICAS SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTÓLOGOS DE LAS IPRESS PÚBLICAS DEL NIVEL I DE LA DIRIS LIMA CENTRO

INDICACIONES: Luego de analizar la operacionalización de variables y los ítems del instrumento determine si éste reúne los indicadores. Evalúe de acuerdo a la valoración siguiente:

Muy bueno (81%-100%),	Bueno (61%-80%),	Regular (41%-60%),	Malo (21%-40%),	Muy malo (1%-20%).
--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Marque con un aspa (x) la apreciación correspondiente en el casillero.

N°	INDICADORES	DEFINICIÓN	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Preguntas con correspondencia y relación adecuada de todas las partes que forman un todo.	X				
2	Relevancia	Preguntas esenciales e importantes que deben ser incluidas.	X				
3	Validez	Preguntas correctas y eficaces que se ajusta a la ley valor.	X				
4	Organización	Preguntas estructuradas con orden y de acuerdo con indicadores propuestos.	X				
5	Claridad	Preguntas redactadas con expresiones entendibles por el encuestado.	X				
6	Precisión	Preguntas con exactitud y determinación.	X				
7	Coherencia	Las preguntas guardan relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	X				
8	Suficiencia	La cantidad de preguntas asignadas a cada dimensión es la adecuada.	X				
Observaciones							

Nombres y Apellidos del experto	ANTONIA CASTRORODRÍGUEZ
Grado Académico	DOCTOR
Institución donde labora	UNMSM
Fecha de validación	17 NOVIEMBRE 2023
DNI	07215663
Firma	

JUICIO DE EXPERTOS -VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

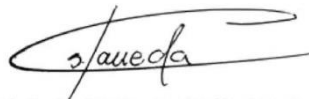
PRÁCTICAS SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTÓLOGOS DE LAS IPRESS PÚBLICAS DEL NIVEL I DE LA DIRIS LIMA CENTRO

INDICACIONES: Luego de analizar la operacionalización de variables y los ítems del instrumento determine si éste reúne los indicadores. Evalúe de acuerdo a la valoración siguiente:

Muy bueno (81%-100%),	Bueno (61%-80%),	Regular (41%-60%),	Malo (21%-40%),	Muy malo (1%-20%).
--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Marque con un aspa (x) la apreciación correspondiente en el casillero.

N°	INDICADORES	DEFINICIÓN	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Preguntas con correspondencia y relación adecuada de todas las partes que forman un todo.	X				
2	Relevancia	Preguntas esenciales e importantes que deben ser incluidas.	X				
3	Validez	Preguntas correctas y eficaces que se ajusta a la ley valor.	X				
4	Organización	Preguntas estructuradas con orden y de acuerdo con indicadores propuestos.	X				
5	Claridad	Preguntas redactadas con expresiones entendibles por el encuestado.	X				
6	Precisión	Preguntas con exactitud y determinación.	X				
7	Coherencia	Las preguntas guardan relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	X				
8	Suficiencia	La cantidad de preguntas asignadas a cada dimensión es la adecuada.	X				
Observaciones							

Nombres y Apellidos del experto	SARA CASTAÑEDA SARMIENTO
Grado Académico	DOCTOR
Institución donde labora	UNMSM
Fecha de validación	06-12-23
DNI	21528573
Firma	

JUICIO DE EXPERTOS -VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

PRÁCTICAS SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTÓLOGOS DE LAS IPRESS PÚBLICAS DEL NIVEL I DE LA DIRIS LIMA CENTRO

INDICACIONES: Luego de analizar la operacionalización de variables y los ítems del instrumento determine si éste reúne los indicadores. Evalúe de acuerdo a la valoración siguiente:

Muy bueno (81%-100%),	Bueno (61%-80%),	Regular (41%-60%),	Malo (21%-40%),	Muy malo (1%-20%).
--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Marque con un aspa (x) la apreciación correspondiente en el casillero.

N°	INDICADORES	DEFINICIÓN	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Preguntas con correspondencia y relación adecuada de todas las partes que forman un todo.	X				
2	Relevancia	Preguntas esenciales e importantes que deben ser incluidas.	X				
3	Validez	Preguntas correctas y eficaces que se ajusta a la ley valor.	X				
4	Organización	Preguntas estructuradas con orden y de acuerdo con indicadores propuestos.	X				
5	Claridad	Preguntas redactadas con expresiones entendibles por el encuestado.	X				
6	Precisión	Preguntas con exactitud y determinación.	X				
7	Coherencia	Las preguntas guardan relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.	X				
8	Suficiencia	La cantidad de preguntas asignadas a cada dimensión es la adecuada.	X				
Observaciones							

Nombres y Apellidos del experto	ALEJANDRO ALBERTO CORNEJO GARCÍA
Grado Académico	CD.ESPECIALISTA
Institución donde labora	UNMSM
Fecha de validación	15-DICIEMBRE 2023
DNI	10474146
Firma	

JUICIO DE EXPERTOS -VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

PRÁCTICAS SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTÓLOGOS DE LAS IPRESS PÚBLICAS DEL NIVEL I DE LA DIRIS LIMA CENTRO

INDICACIONES: Luego de analizar la operacionalización de variables y los ítems del instrumento determine si éste reúne los indicadores. Evalúe de acuerdo a la valoración siguiente:

Muy bueno (81%-100%),	Bueno (61%-80%),	Regular (41%-60%),	Malo (21%-40%),	Muy malo (1%-20%).
--------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Marque con un aspa (x) la apreciación correspondiente en el casillero.

N°	INDICADORES	DEFINICIÓN	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
1	Consistencia	Preguntas con correspondencia y relación adecuada de todas las partes que forman un todo.		X			
2	Relevancia	Preguntas esenciales e importantes que deben ser incluidas.		X			
3	Validez	Preguntas correctas y eficaces que se ajusta a la ley valor.		X			
4	Organización	Preguntas estructuradas con orden y de acuerdo con indicadores propuestos.		X			
5	Claridad	Preguntas redactadas con expresiones entendibles por el encuestado.		X			
6	Precisión	Preguntas con exactitud y determinación.		X			
7	Coherencia	Las preguntas guardan relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo.		X			
8	Suficiencia	La cantidad de preguntas asignadas a cada dimensión es la adecuada.		X			
Observaciones							

Nombres y Apellidos del experto	JHAMES IVAN ORE DE LA CRUZ
Grado Académico	DOCTOR
Institución donde labora	UNMSM – HNAL
Fecha de validación	18-01-24
DNI	20576287
Firma	

Anexo 9. Prueba V de Aiken del instrumento para evaluar el nivel de Prácticas sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

V DE AIKEN - CUESTIONARIO DE PRÁCTICAS					
DIMENSIÓN	PREGUNTAS/ ITEMS	CLARIDAD	COHERENCIA	RELEVANCIA	SUFICIENCIA
Uso de barreras de protección	1	1	1	1	1
	2	1	1	1	
	3	1	1	1	
	4	1	1	1	
	5	1	1	1	
Manejo y eliminación de residuos	6	1	1	1	1
	7	1	1	1	
	8	1	1	1	
	9	1	1	1	
	10	1	1	1	
	11	1	1	1	
Medidas ante accidentes de exposición a sangre y fluidos corporales	12	1	1	1	1
	13	1	1	1	
	14	1	1	1	
	V DE AIKEN	1	1	1	1

Anexo 10. Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Investigadora: Bach. Annie Lizet Caruajulca Cieza

Título del estudio: Nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

Estimado(a) participante, a continuación, se le brinda el Consentimiento Informado, por favor léalo cuidadosamente antes de decidir su participación.

-Propósito del estudio: Lo invitamos a participar del presente estudio de investigación el cual busca determinar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

-Procedimiento: Si usted acepta participar en este estudio, deberá responder a los cuestionarios físicos en su totalidad, le tomará un aproximado de 20 minutos.

-Riesgos y beneficios: Ud. no presentará algún riesgo por participar del estudio; así mismo, no se presentarán beneficios directos por su participación, simplemente el agradecimiento por contribuir con su apoyo en la investigación.

-Costos y compensación: Al participar del estudio usted no deberá pagar algún costo, ni tampoco recibirá algún incentivo económico o de otra índole.

-Confidencialidad de la Información: Se guardará absoluta confidencialidad con toda la información que Ud. entregue. En ningún momento se revelará su identidad. Al presentar los resultados del estudio no serán utilizados sus datos o respuestas que permitan individualizarlo. La información será archivada digitalmente bajo contraseña y será usada sólo por la investigadora para fines de la presente investigación.

-Derechos del participante: Su participación en el estudio es completamente voluntaria. Recuerde que usted también puede retirarse del estudio en el momento que estime conveniente, sin que esto le ocasione perjuicio alguno.

Ante cualquier duda e inquietud puede contactarse con la investigadora Email: annie.caruajulca59@mail.com Celular: 980796119

Datos de Contacto del Comité de Ética

(Para preguntas sobre sus derechos como voluntario, o si piensa que sus derechos han sido vulnerados).

Puede contactarse con:

Presidente del Comité de Ética: Dr. Fernando Alfonso Ortiz Culca

Dirección: Germán Amezaga s/n. Lima. Facultad de Odontología UNMSM.

Correo electrónico: comitedeetica.fo@unmsm.edu.pe

Declaración de Consentimiento

Declaro que se me ha explicado de forma clara el propósito del estudio, la manera cómo se realizará y los procedimientos a seguir. Además, he tenido la oportunidad de realizar todas las preguntas que considere necesarias, las cuales fueron respondidas a satisfacción. Que no he sido coaccionado, ni influido indebidamente a participar en el estudio.

Finalmente acepto voluntariamente participar del estudio.

.....

Nombres y Apellidos del
participante

.....

Firma

.....

Fecha

.....

Nombres y Apellidos de la
Investigadora

.....

Firma

.....

Fecha

Anexo 11. Constancia de Aprobación del Comité de ética



""Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho""

CONSTANCIA DE APROBACIÓN N°084-CEI-FO-2024

El Comité de Ética Institucional de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha **APROBADO** el proyecto de investigación: **“NIVEL DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTÓLOGOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICAS DEL NIVEL I DE LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO”**, a cargo de la investigadora principal **ANNIE LIZET CARUAJULCA CIEZA**.

La presente aprobación del Comité de Ética Institucional de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene una vigencia de tres años, del 18 de noviembre de 2024 al 18 de noviembre de 2027 bajo los siguientes considerandos:

- El proyecto de investigación se encuentra registrado y almacenado en los archivos digitales del comité.
- Los datos obtenidos de la investigación deberán ser rigurosamente resguardados y almacenados por un periodo mínimo de tres años pudiendo ser solicitados por este comité en cualquier momento.
- El comité se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento un informe del avance del proceso de ejecución del proyecto de investigación
- Cualquier modificación al proyecto presentado deberá ser informado al Comité.
- Al finalizar la ejecución el investigador responsable debe enviar una copia del informe final a este comité.
- El Comité de Ética está a disposición para posteriores esclarecimientos o dudas.

Ciudad Universitaria, 18 de noviembre de 2024

Dr. Fernando Alfonso Ortiz Culca
Presidente del Comité de Ética Institucional
Facultad de Odontología

Anexo 12. Carta de presentación de la FO hacia la DIRIS Lima Centro.



Firmado digitalmente por PETKOVA
GUEORGUEVA DE RODRIGUEZ
Marieta FAU 2014002282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.12.2024 13:24:50 -0500

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. Decana de América
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
DECANATO

Lima, 05 de Diciembre del 2024

CARTA DE PRESENTACIÓN N° 000059-2024-D-FO/UNMSM

Doctora
Delia Florencia Dávila Vigil
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO
Presente. -

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y, a la vez, presentar a la Bach. ANNIE LIZET CARUAJULCA CIEZA identificada con DNI 71981137, con código de matrícula n.º 17050016, egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Marcos, quien se encuentra desarrollando la tesis titulada "NIVEL DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ODONTÓLOGOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICAS DEL NIVEL I DE LA DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO".

Al respecto, la mencionada bachiller desea ejecutar su proyecto de tesis en la institución que usted dignamente dirige. Por tal motivo, solicito respetuosamente a su despacho brindar las facilidades pertinentes la Br. ANNIE LIZET CARUAJULCA CIEZA para que realice su recolección de datos para su trabajo de investigación.

Agradezco su amable atención, sea propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Mg. Marieta Petkova Gueorgueva De Rodriguez
DECANA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA(e)

MPG/pcs

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://spsgd.unmsm.edu.pe/verificafinicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: LQSEDJX



Anexo 13. Matriz de consistencia

Formulación del problema	Objetivos	Variables	Metodología
¿Cuál es el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, en el año 2024?	General: Determinar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, en el año 2025. Específicos: -Identificar el nivel de conocimientos sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, según edad y sexo. -Evaluar las actitudes sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, según edad y sexo. -Identificar las prácticas en cuanto a medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, según edad y sexo. -Establecer la relación entre el nivel de conocimientos, las actitudes y las prácticas sobre las medidas de bioseguridad en odontólogos de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas del nivel I de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.	Variables: - Nivel de conocimiento sobre las medidas de bioseguridad. - Nivel de actitudes sobre las medidas de bioseguridad. - Nivel de prácticas sobre las medidas de bioseguridad. Covariables: - Edad - Sexo	Tipo de investigación Estudio descriptivo y transversal. Población y muestra Población 130 odontólogos, de los cuales la muestra la conformarán la totalidad de la población. Procesamiento de datos Por medio de programa SPSS versión 25. Análisis de datos La estadística inferencial se desarrollará a través de la prueba Chi cuadrado, la prueba T de student y ANOVA unidireccional para evaluar las diferencias entre grupos, y el coeficiente de correlación de Spearman para la asociación significativa entre categorías. Se utilizará un nivel de confianza del 95% y error tipo I del 5%.

Anexo 14. Clasificación de los instrumentos, dispositivos y equipos odontológicos según Spaulding como críticos, semicríticos y no críticos.

CLASIFICACIÓN	DEFINICIÓN	EJEMPLOS	MÉTODO
CRÍTICOS	Son los que se utilizan para penetrar en los tejidos blandos y duros como diente y hueso; y por tanto presenta mayor riesgo de transmitir infecciones	Instrumentos quirúrgicos. Raspadores periodontales. Fresas dentales. Limas de endodoncia.	Esterilización en autoclave (calor húmedo). Esterilización en estufa (calor seco).
SEMICRÍTICOS	Son aquellos que entran en contacto con mucosas o piel no intacta. No penetran tejido blando ni contacta con el torrente sanguíneo del paciente.	Espejo bucal, pinza y explorador Cubetas de impresión Turbina, micromotor, ultrasonido. Instrumental de cementación Alicates de ortodoncia Lámpara de fotocurado, etc. Materiales para laboratorio: impresiones, aparatos protésicos y ortodónticos.	Esterilización de ser posible. Desinfección de alto nivel Desinfección de intermedio nivel.
NO CRÍTICOS	Solamente entran en contacto con piel sana.	Cabezal y/o cono de radiografía. Arco facial. Cadena para colocar campos. Cámara fotográfica. Espejo facial para paciente.	Limpieza y desinfección de intermedio nivel y bajo nivel.

Fuentes: DIRECTIVA SANITARIA N°100/MINSA/20202/DGIESP. Manejo de la atención estomatológica en el contexto de la pandemia por COVID-19. 2020.

COL. Líneas guía para la atención odontológica en el periodo de la crisis por COVID-19. 2020

Anexo 15. Medidas complementarias a la exposición del virus de la hepatitis B (VHB)

Si Fuente de contacto	Y Personal de salud	El trabajador de salud
Se encuentra positiva para HBsAg	No está vacunado contra la hepatitis B	1. Debe recibir esquema de vacunación contra hepatitis B 2. Debe recibir dosis única HBIg en los primeros 7 días.
	Sí está vacunado contra la hepatitis B	Debe medirse anti-HBs y si es <10mU aplicar una dosis de HBIg y vacuna de refuerzo
Se encuentra negativa para HBsAg	No está vacunado contra la hepatitis B	Debe recibir vacuna contra hepatitis B
	Sí está vacunado contra la hepatitis B	No requiere ninguna medida
Se niega a analizar su sangre o no se identifica la fuente de contacto	No está vacunado contra la hepatitis B	1. Debe recibir esquema de vacunación 2. Si fuente es de alto riesgo o sospechosa de HBsAg debe recibir HBIg en los primeros 7 días.
	Sí está vacunado contra la hepatitis B	Tendrá un manejo individualizado para cada caso

FUENTE: UPCH “Control de las Infecciones Transmisibles en la Práctica Odontológica

HBsAg: Antígeno de superficie para Hepatitis B

HBIg: Inmunoglobulina específica para Hepatitis B (DOSIS: 0.06 ml/kg)

Anti-HBs: Anticuerpos contra antígeno de superficie para hepatitis B

Anexo 16. Establecimientos de Salud de la DIRIS Lima Centro que cuentan con el servicio de odontología, según RIS y distrito.

RIS	DISTRITO	ESTABLECIMIENTO DE SALUD
RIS 1	Cercado de Lima	- C.S. MIRONES - C.S. MIRONES BAJO - C.S. UNIDAD VECINAL NRO 3 - C.S. VILLA MARIA PERPETUO SOCORRO - C.S. CONDE DE LA VEGA - C.S. SAN SEBASTIAN - C.S. JUAN PEREZ CARRANZA - C.S. RAUL PATRUCCO PUIG - C.S. CONTROL DE ZOONOSIS - P.S. EL RESCATE - P.S. SANTA ROSA - P.S. PALERMO - P.S. JARDIN ROSA DE SANTA MARÍA
RIS 2	Breña	- C.S. BREÑA - C.S. CHACRA COLORADA
	Magdalena	- C.S.M.I MAGDALENA
	Jesús María	- C.S. JESUS MARIA
	San Miguel	- C.S. SAN MIGUEL - P.S. HUACA PANDO
RIS 3	Lince	- C.S. LINCE
	Surquillo	- C.S. SAN ATANACIO DEL PEDREGAL - C.S. VILLA VICTORIA PORVENIR - C.S.M.I SURQUILLO
	San Isidro	- C.S. SAN ISIDRO
	Miraflores	- C.S. MIRAFLORES
RIS 4	La Victoria	- C.S. MAX ARIAS SCHREIBER - C.S. EL PINO - C.S. SAN COSME - C.S.M.I EL PORVENIR - P.S. CLAS EL PINO
	San Luis	- C.S. SAN LUIS
	San Borja	- C.S. TODOS LOS SANTOS SAN BORJA - P.S. SAN JUAN MASÍAS
RIS 5	SJL	- C.S. CHACARILLA DE OTERO - C.S. CAJA DE AGUA - C.S. ZARATE - C.S. CAMPOY - C.S. SAN FERNANDO - C.S. LA LIBERTAD - C.S. LA HUAYRONA - C.S. MANGOMARCA - C.S. SANTA ROSA DE LIMA - C.S. SANTA FE DE TOTORITA - C.S. DANIEL A. CARRIÓN - P.S. AZCARRUNZ ALTO - P.S. 15 DE ENERO
RIS 6	SJL	- C.S. GANIMEDES - C.S. SAN HILARIÓN - C.S. HUASCAR II - C.S. HUASCAR XV - C.S. BAYOVAR - C.S. MEDALLA MILAGROSA - P.S. AYACUCHO - P.S. PROYECTOS ESPECIALES - P.S. SAGRADA FAMILIA
RIS 7	SJL	- C.S. JAIME ZUBIETA - C.S. JOSE C. MARIATEGUI - C.S. CRUZ DE MOTUPE - C.S. SANTA MARÍA - C.S. ENRIQUE MONTENEGRO - C.S. 10 DE OCTUBRE - C.S. SU SANTIDAD JUAN PABLO II - P.S. TUPAC AMARU II - P.S. JOSE C. MARIATEGUI V ETAPA - P.S. MARISCAL CACERES - P.S. CESAR VALLEJO